Asociación de Psicopatología
y Psicoanálisis de Sevilla

**JOSÉ MANUEL GARCÍA ARROYO**

# COMUNICACIÓN ASISTENCIAL PARA MÉDICOS

## II PARTE: LA COMUNICACIÓN ASISTENCIAL COMO PROCESO SOCIAL INTERACTIVO




El presente libro ha recibido la MENCIÓN DE HONOR
del Grupo de Investigación para la Salud en Ciencias Humana (IPSUM)

Comunicación Asistencial para Médicos. II Parte: La Comunicación Asistencial como proceso social interactivo

José Manuel García Arroyo

Editado por la Asociación de Psicopatología y Psicoanálisis de Sevilla

Luis Montoto, 83 – 3º C

41018 Sevilla (España)

luysa.dl@gmail.com

ISBN: 978-84-09-31608-3

Depósito Legal: SE-394-21

Diseño, maquetación e impresión: Gabella Artes Gráficas.

Impreso en España. Printed in Spain.

Reservados todos los derechos.

Queda rigurosamente prohibido, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en la ley, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamo público.

Mejor pues que renuncie quién no pueda unir su horizonte a la subjetividad de la época.

JACQUES LACAN

Dedicado a la memoria de mi madre, que hizo lo que buenamente pudo con lo que le tocó vivir.

**INDICE**

**PRESENTACIÓN.**

**SEGUNDA PARTE. La comunicación asistencial como proceso social interactivo.**

**Capítulo 3º. La relación clínica. Concepto, características, momentos. Componentes formales y subjetivos. Distorsiones.**

3.1. Concepto de relación clínica.

3.2. Características de la relación clínica.

3.3. Momentos de la relación clínica.

3.3.1. Cognoscitivo.

3.3.2. Operativo.

3.3.3. Afectivo.

3.3.4. Ético (o social).

3.4. Distorsiones de la relación clínica.

**Capítulo 4º. Los Modelos Asistenciales: centrado en el médico, en el paciente, en la mutua colaboración, en la sociedad.**

4.1. Los modelos asistenciales y su clasificación.

4.1.1. El modelo de los roles.

4.1.2. El modelo de participación.

4.1.3. El modelo basado en el objetivo de la relación.

4.1.4. El modelo basado en el grado de control.

4.2. la relación médico-paciente en los modelos asistenciales clásicos.

4.2.1. El modelo médico.

4.2.2. El modelo biopsicosocial.

4.2.3. El modelo centrado en el paciente.

4.3. Interferencias en la relación médica.

4.3.1. Los aspectos cognitivos.

4.3.2. Los aspectos afectivos.

4.3.3. Los aspectos sociales.

**<u>Capítulo 5º</u>. Desarrollo y aprendizaje de habilidades de comunicación (I). a) De contenido: la Narrativa Médica. b) Procesuales: técnicas, herramientas y estrategias.**

5.1. Importancia de las habilidades de comunicación en Medicina.

5.2. Habilidades de contenido.

5.2.1. Concepto de narrativa.

5.2.2. La Narrativa Médica.

A. Origen.

B. Antecedentes.

C. La historia clínica como narración.

D. La Competencia Narrativa del médico.

E. Desarrollo de la Competencia Narrativa.

F. Resultados de la Narrativa Médica.

5.3. Habilidades procesuales.

5.3.1. El vaciamiento de la información.

5.3.2. La escucha activa.

5.3.3. Técnicas y estrategias.

A. Para que el paciente se exprese.

B. Para que el paciente tome conciencia.

**<u>Capítulo 6º</u>. Desarrollo y aprendizaje de habilidades de comunicación (II): c) Cognitivo-emocionales: actitud ante las emociones, empatía clínica y asertividad. d) De objeto: diagnóstico, pronóstico y tratamiento.**

6.1. Actitud del médico ante las emociones.

6.1.1. Captarlas.

6.1.2. Reconocerlas.

6.1.3. Operar.

6.2. La empatía clínica.

6.2.1. Concepto de empatía.

6.2.2. Niveles de desarrollo de la empatía.

6.2.3. Fundamentos.

6.2.4. Equilibrio de empatía.

6.2.5. La empatía en el contexto terapéutico.

6.3. La asertividad.

6.3.1. ¿Qué es la asertividad?

6.3.2. La asertividad en el ámbito clínico.

A. La Medicina Defensiva.

B. La Medicina Asertiva.

**Capítulo 7º. La entrevista clínica: concepto, encuadre, tipos, movimientos afectivos y fases.**

7.1. ¿En qué consiste una *entrevista clínica* (EC)?

7.2. El encuadre.

7.2.1. El espacio.

7.2.2. El tiempo.

7.2.3. La técnica.

A. Empatía.

B. Calidez.

C. Respeto.

D. Concreción.

7.3. Tipos de entrevista.

7.4. Movimientos afectivos durante la entrevista.

7.5. Fases de la entrevista.

7.5.1. Apertura.

7.5.2. Desarrollo.

7.5.3. Cierre.

## PRESENTACIÓN.

El primero de los libros publicados en esta serie titulada “Comunicación Asistencial para Médicos”, trataba sobre el proceso comunicativo en toda su amplitud y extensión, detallando las funciones y los elementos que lo componían. Aunque se hicieron entonces pequeñas incursiones al territorio de la Medicina, lo que allí se dijo tiene una aplicación general, es decir, que puede emplearse en cualquier parcela del saber donde se dé una interacción humana (periodismo, relaciones laborales, derecho, pedagogía, enfermería, etc.).

Por el contrario, la materia que se presenta en este segundo volumen se caracteriza por adentrarse directamente en el quehacer del médico. Este cambio puede incrementar el interés del lector, pues va a descubrir la existencia de relaciones recíprocas entre lo investigado en Comunicación y la Práctica Médica. Con esta nueva propuesta se espera que no se quede lo ya expuesto en mera teoría, sino que se le vea su incuestionable vertiente práctica.

El desarrollo temático que aquí se sigue tiene un desarrollo lógico aplastante pues respeta la manera de enseñar en Medicina, favoreciendo la asimilación. Se comienza analizando la Relación Médico-Enfermo (RME), un tema sustraído a la Psicología Médica y que tiene más sentido tratarlo aquí; la razón es que, sobre ella, se levanta todo el edificio de la Comunicación Asistencial. Continúa con la presentación de los diferentes Modelos Asistenciales, ya que estos van a constituirse en contextos (normativos, legislativos) en los que el médico tiene que trabajar.

Una vez planteados ya estos dos asuntos de cabecera, tenemos la base para empezar a tratar los procesos comunicativos en sí mismos y aquí es donde entran las habilidades de comunicación a desarrollar por el médico. Entramos en una parte sumamente práctica que aborda:

-La *narrativa médica*, una adquisición bastante reciente. Mediante ella es posible descubrir, no sin cierto asombro, que estamos metidos en narraciones, aunque no lo sepamos o no lo queramos; nuestra propia vida es una narración. Ciertamente, cuando se cuenta cualquier experiencia por la que hayamos pasado, lo expuesto adopta la forma de un relato. Con estos fundamentos, la historia clínica y las elaboraciones que el médico haga sobre ella permiten compartir la información y, sobre todo, plantear puntos de vista diferentes. Aquí hay que considerar el punto de vista subjetivo de cada cual, ya que no existe una “verdad absoluta” o “definitiva”, sino perspectivas con las que tenemos que convivir. Esta aseveración tiene hoy en día sustentos teóricos, en personajes de la talla del sociólogo Zygmunt Bauman, en su “mundo líquido” (1). Por nuestra parte, también defendido esta postura y la hemos denominado “efecto subjetividad” (2).

La caída de los sistemas totalitarios, que postulaban la “verdad única” ha dado paso a los sistemas democráticos, en los cuáles cada cual tiene su “verdad” (léase “certidumbre subjetiva”) y lo único que cabe en un mundo así es respetar el punto de vista ajeno para, a su vez, ser respetados. La convivencia de distintas creencias e ideologías es lo que caracteriza a la sociedad moderna y es a lo que el médico tiene que acostumbrarse para actuar en su práctica diaria.

La narrativa médica, como veremos, sigue esta línea y tiene en cuenta los diferentes puntos de vista. Pero, esta también posibilita al médico dos formas de comunicación: la *interpersonal*, con los pacientes o con los demás miembros de su comunidad científica, y la *intrapersonal,* que le permite el “diálogo interior” necesario para poder elaborar las variopintas situaciones que vive en su práctica diaria. Al psicólogo ruso Lev Vygotsky, llamado el “Mozart de la psicología” por su muerte prematura, se le considera el padre del “lenguaje interior”, al separar este último del “lenguaje social" que usamos para interactuar con los demás (3).

-Los diferentes modos de intervención útiles en la consulta, que se constituyen en estrategias para lograr que el paciente se exprese y que también se dé cuenta de algo importante, arrojando cierta iluminación sobre su enfermedad o sobre un problema psicológico que plantea.

-Manejar la parte afectiva resulta fundamental, dado que cualquier patología desencadena respuestas afectivas, al constituirse en un fenómeno indeseado que frustra y priva de alternativas. La empatía es un asunto del que no se puede prescindir en este texto, ya que permite al médico plantearse cómo se sentiría si le pasara lo mismo que a la persona que tiene delante; evidentemente, para que un mensaje llegue a su destino hace falta saber cómo se encuentra el receptor. Pero, cuidado, porque esta acción no es tan sencilla como parece, pues se trata de un equilibrio: sumergirse en el mundo del otro pero sin ahogarse en él. Esto indica que la labor de cuidado del médico tiene límites y traspasarlos se paga muy caro. Existe el peligro de convertirse en un “médico quemado” y llegar a odiar la profesión; contamos ya con numerosos casos estudiados por nosotros (4).

-Para terminar con el texto, se presenta la entrevista como pieza clave de todo el entramado comunicativo, pues es en ella donde cristaliza todo lo aprendido con anterioridad. Aún existen médicos que creen no necesitar ninguna interacción con sus pacientes y mucho menos conocer su vida; se trata de actitudes que, afortunadamente, están remitiendo. En este orden de cosas, se le está dando cada vez más valor a los hechos vividos por los pacientes (*life events*) ya que de ellos dependerán los planteamientos relativos a su enfermedad. Hemos visto esto frecuentemente en mujeres con cáncer de mama, cuyos afrontamientos a la enfermedad y perspectivas de futuro tenían que ver con ciertos antecedentes familiares (p. ej. madre o abuela con la misma enfermedad). Nadie puede dudar

ya del interés que estos aspectos suscitan y la entrevista es un modo de obtener información de primera mano sobre estos temas, además de completar con datos insospechados la historia clínica, construyendo una narrativa cargada de detalles relacionados entre sí. Solo así, con estos instrumentos, el médico puede construir una mente asociativa.

Seguimos la misma forma de exposición que en el texto precedente: explicando la parte teórica mediante el concurso de casos reales. Hay que advertir que algunos de ellos muestran una temática un poco fuerte, como podrá comprobarse, pero no queremos renunciar a ella, ya que pensamos que el estudiante de Medicina tiene que acostumbrarse a escuchar las confidencias de los pacientes, que es lo que sucederá en su práctica futura. De ahí que no esté en nuestro ánimo meter la tijera de la censura, para ofrecer al lector un material inédito y que cuente con la suficiente fuerza expresiva para que el estudiante sepa a lo que tendrá que enfrentarse e irse preparando para aportar las respuestas más certeras.

**BIBLIOGRAFÍA.**

1. Bauman Z. Vida líquida. Madrid: Planeta, 2013.
2. García Arroyo JM. El cáncer de mama (2): metodología de la subjetividad. Punto Rojo, 2016.
3. Vygotsky L. Pensamiento y lenguaje. Barcelona: Paidós, 2020.
4. García Arroyo JM. Subjective aspects of Burnout Syndrome in the Medical Profession. Psychology 2014: 5(18): 2064-2072.

# SEGUNDA PARTE. LA COMUNICACIÓN ASISTENCIAL COMO PROCESO SOCIAL INTERACTIVO

## Capítulo 3º. La relación clínica. Concepto, características, momentos. Componentes formales y subjetivos. Distorsiones.

### 3.1. Concepto de relación clínica.

Los principios generales sobre Comunicación que se han estudiado en los capítulos 1º y 2º van a aplicarse ahora al contexto clínico pero, antes de entrar de lleno en el estudio de las distintas habilidades que el médico tiene que emplear en el contacto con sus pacientes, resulta imperativo tratar de definir qué es la Relación Médico-Enfermo (capítulo 3º) y los modelos que pueden aplicarse a esta (capítulo 4º).

La *relación clínica* es una forma de relación social con características muy particulares. Cabe entenderla como la vinculación que se produce entre una persona que sufre y un profesional capacitado para aliviarle el sufrimiento o curarlo y prevenir la recaída. De remontarnos a tiempos pasados es posible que algunos de los elementos que aparecen en esta definición no estuvieran, de ahí que tengamos que precisarlos un poco más:

1. Se elude el término "diagnóstico", que apunta a una "relación para diagnosticar". Antaño lo fundamental del contacto médico-paciente era producir un saber que concentrara las manifestaciones displacenteras del último de ellos en una diagnóstico; en tal caso, el médico ejemplar era el que mejor diagnosticaba. Hoy en día este planteamiento ha caído por su peso, ya que el diagnóstico es necesario pero no lo que define la relación.

Aquel profesional de la medicina que busque el diagnóstico incesantemente con el fin de autoproclamarse como "extraordinario", cae inexorablemente en el "narcisismo médico". Una faceta de este último consiste en vanagloriarse de haber llegado a un diagnóstico a pesar de lo abigarrado de la clínica que el enfermo presentaba. Resulta común que a estos profesionales les moleste cuando no pueden filiar a un paciente en un cuadro conocido por él y, sin embargo, esta posibilidad es verdaderamente frecuente en la clínica. Tal es el caso de los pacientes psicosomáticos o los llamados "enfermos-problema" en los que existe una discordancia entre las producciones (sintomáticas) subjetivas y lo que puede objetivarse del cuadro (p. ej. lesiones demostrables, analíticas alteradas, etc.). El médico narcisista intenta sacudirse cuanto antes a estos sujetos, pues le hacen sentirse humillado, al no poder hacer lo que creen que es la acción más importante de un médico: saber qué enfermedad padecen y filiarla correctamente.

2. La definición habla de "aliviar", no solo de "curar". Ya se dijo en el primer volumen de esta colección que se ha producido en los últimos tiempos un aumento de los enfermos crónicos que resultan incurables, dado que la enfermedad es persistente. Luego, son pacientes que pueden seguir diferentes

evoluciones: en el mejor de los casos se mantienen estables, pero puede ser que se vaya produciendo un deterioro progresivo que les produzca importantes discapacidades o, en el peor de los casos, que les lleve a la muerte. En cualquiera de estas posibilidades, aunque se trate de casos imposibles de curar, el médico sí que puede aliviar el malestar de la enfermedad, dado que cuenta con los medios adecuados para realizarlo (p. ej. mejorar el dolor, la sensación nauseosa, los vértigos, la fatigabilidad, el desánimo, la apatía, etc.).

Aquellos médicos que solo quieren curar, padecen lo que llamamos *furor curandis* y suele tratarse de jóvenes idealistas que sueñan con una medicina ideal en la que el profesional de la medicina puede hacer mucho más de lo que hace. Finalmente, la realidad se impone en la nuestra profesión y se reducen las expectativas ideales, considerando que muchos pacientes no tienen cura.

3. Incluye la palabra “prevenir”. Trátase de una labor introducida en los últimos tiempos en el campo de la Medicina, que se conecta directamente con lo que se llama en Psicología Médica “conductas de riesgo”. Cualquier maniobra del médico para hacer que el paciente comprenda que sus comportamientos pueden provocarle la enfermedad o impedir la evolución negativa, si ya la padece, entra dentro de su trabajo y convierte al médico en un educador. En este sentido, la “educación médica” está tomando bastante predicamento en los últimos tiempos (1).

La relación clínica se genera a partir de la demanda de una persona provocada por el síntoma, una forma de sufrimiento que resulta indeseable, y que da lugar a la respuesta por parte del médico. El primero de ellos, interpreta como “síntoma” ese displacer físico que tiene, lo cual solo es posible si pertenece a un medio social en el que se impone la cultura médica; es esta última la que propone y divulga códigos de interpretación de un malestar (físico) como “síntoma”. Esto no ocurre en otros lugares del planeta donde tal implantación no se ha realizado y la intelección que se realiza, utiliza otros signos completamente diferentes.

> *Es frecuente en los países africanos en los que la Medicina no se encuentra implantada, plantear el malestar físico como una posesión por los espíritus malignos. Es el chamán, como intermediario entre el mundo natural y espiritual, el encargado de liberar al sujeto de esos efectos negativos utilizando el estado trance. Tal efecto se consigue debido a la fuerte ascendencia que tienen en sus comunidades, a su vez basada en las creencias mágicas (2).*

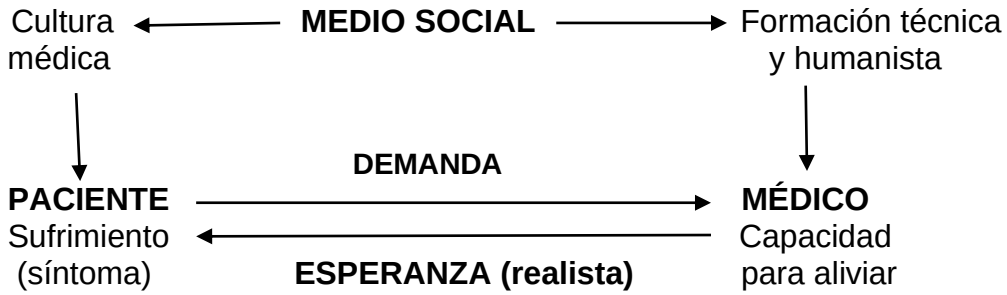
Dentro de la cultura médica en la que nos insertamos, se le supone al médico una preparación técnica y humanista que le capacita para aliviar (o, en el mejor de los casos, curar), el malestar de quién le consulta.

*Salvando distancias, se trata de un fenómeno idéntico al que le sucede con los chamanes en otras culturas, a los cuáles los miembros de una comunidad les dota automáticamente de poderes mágicos y, sobre todo, de la capacidad singular para contactar con el más allá y sus moradores, lo que les capacita para dominar la enfermedad (2).*

La demanda puede ser *real*, en el caso de que se trate de una patología demostrable, o *imaginaria* en la que, a pesar de la exploración y las técnicas empleadas para el diagnóstico, no se demuestra patología alguna. Esto último sucede en los hipocondríacos y en los trastornos por somatización.

Sea como fuere, el médico siempre tiene que transmitir esperanza al paciente, aunque eso sí, una esperanza de carácter realista. Hipócrates dejó escrito que el médico debe: "curar a veces, aliviar en ocasiones y consolar siempre". Los enfermos deben saber que tenemos soluciones para su problema, aunque estas no sean las definitivas.

El adjetivo "realista" significa: a) indicar que se le puede a ayudar, b) dentro de las posibilidades existentes, indicando qué se puede conseguir y qué no y c) nunca intentando engañarlo sobre su padecimiento. Lo que no toleran los pacientes es la mentira, mucho peor que una mala noticia, ya que el falseamiento de una realidad puede provocar conflictos en la relación clínica e incluso producir su ruptura definitiva (ver capítulo 11º, sobre las "malas noticias"). Por consiguiente, está totalmente proscrito hacerle falsas promesas al paciente.




### 3.2. Características de la relación clínica.

Se analizan a continuación aquellas particularidades que definen de forma clara a la relación clínica, para conseguirlo realizamos un movimiento que va desde lo más general a lo particular:

a) Es una relación social, como ya se indicó al principio del capítulo, de manera que tiene lugar en ella un contacto interpersonal. Por lo tanto, no se trata de una relación entre un paciente y una máquina o un dispositivo mecánico (para diagnosticarlo, para intervenirlo o para darle una respuesta).

*Cuando un periodista le preguntó al Dr. D. Gregorio Marañón cuál había sido el avance más importante que había tenido la Medicina, todo el mundo pensaba que respondería: el fonendoscopio, los rayos X, los antibióticos, la anestesia, etc. Sin embargo, el afamado doctor respondió serenamente: ¡la silla! Si, la silla desde la que escuchar a los pacientes; para él lo más importante era lo que estos contaban y, dedicar un tiempo a hablar con ellos, seguía siendo uno de los aspectos fundamentales de la Relación Médico-Enfermo, punto de vista que intentaba inculcar a sus numerosos discípulos.*

b) Se forma una diada. En la relación clínica concurren dos personas: el paciente y el médico, aunque, a veces, pueden existir más dado que la pareja, la familia, un amigo, etc. puede acudir a la consultar como acompañantes. Estos últimos conforman una ampliación del paciente, pero en puridad no forman parte de la relación clínica.

c) La relación es asimétrica. Existe una desigualdad entre los miembros de esta relación dado que el médico es el que tiene el saber y el paciente va a aprovecharlo para su mejoría. La asimetría se define solo en términos profesionales, ya que como seres humanos todos tenemos el mismo valor.

Siguiendo el 5º axioma de la Escuela de Palo Alto (ver capítulo 1º), estamos hablando de una relación "complementaria" en la que se establece un contacto de superioridad-inferioridad (en términos de conocimiento) y, como ya se indicó, este matiza el tipo de comunicación que se establece; volveremos sobre este asunto.

d) Se basa en el diálogo. Indica esta característica que va a existir un intercambio de palabras entre médico y paciente, donde los papeles de emisor y receptor se alternan (la "intercambiabilidad", ver Capítulo 1º). El contenido del diálogo es la enfermedad, no pudiendo sustraerse a las reglas generales de la comunicación, dado que se requiere sinceridad por parte de ambos participantes en el mismo, de manera que si se produce una interacción en la que se oculta algún material importante la relación se falsea; se trata de un simulacro de relación.

e) Es necesario regular la distancia. Si bien el apartado anterior se refiere a la comunicación verbal, este se dirige en concreto al material no verbal. En efecto, en cualquier contacto que se establezca entre humanos, va a producirse una aproximación (afectiva y física) a medida que la confianza va fluyendo, pero en Medicina este fenómeno tiene que matizarse. Ciertamente que las relaciones con los pacientes son cada vez más prolongadas, dado que podemos tener al mismo paciente con distintos procesos (enfermedades agudas) o el mismo paciente con el mismo proceso (crónicas), en cuyo caso y siguiendo las reglas de la comunicación se produce una aproximación.

No obstante, dado el carácter tan particular de esta relación interpersonal, el médico no puede tratarlo como a un conocido o un amigo, con lo que tiene que regular la distancia la cuál debe de oscilar entre la aproximación y el alejamiento. A título de ejemplo, diremos que no está permitido el compadreo o la camaradería que son formas de una cercanía inapropiada.

f) La finalidad es la ayuda profesional. Tiene que ver con la competencia técnica del médico, quién pone el conocimiento que ha adquirido en la Facultad de Medicina al servicio de la mejoría clínica del paciente.

g) El contexto donde se desarrolla es especial: la consulta médica. Puede incluso decirse que el médico está obligado a realizar sus actos profesionales en este medio y no en otro, salvo excepciones que casi siempre son urgencias (atención domiciliaria, casos que espontáneamente se encuentra en lugares públicos o transportes, etc.).

### 3.3. Momentos de la relación clínica.

Laín Entralgo (3,4) divide la relación clínica en distintos momentos, que pueden ser simultáneos o sucesivos:

**3.3.1. Momento cognoscitivo.** El término “cognoscitivo” alude a modo de conocer y se refiere a cómo se maneja la información. El profesional de la Medicina tiene que conocer el problema y nombrarlo, según sus conocimientos y para ello utiliza el diagnóstico médico, que es una configuración cognoscitiva. Esto no invalida lo que ya se dijo al principio del capítulo, ya que el diagnóstico no es el “todo” de la relación clínica.

Aunque el paciente aporta una interpretación al malestar físico que le lleva a consultar, siempre según sus creencias, estado afectivo y personalidad, es el médico el que da el sentido de “enfermedad” a las molestias que trae. Se trata de una operación en la que se produce la comunicación del diagnóstico, lo que implica a un receptor que debe integrar la información que se le transmite, un proceso que denominamos de *subjetivación*. Más adelante, podremos estudiar este fenómeno con más atención pero sirva ahora decir que, para que se lleve a cabo con naturalidad, hace falta el desarrollo de habilidades de comunicación en ambos miembros de la relación terapéutica:

a) por parte del médico, en tanto sepa transmitirlo adecuadamente (se estudiarán en el capítulo 6º) y

b) por parte del paciente. Al hallarse este inmerso en una cultura en la que la Medicina se constituye en la práctica que soluciona los problemas de salud, tienen que buscar la información necesaria para poder captar e integrar la noticia diagnóstica. Si actúa así, se hace un “experto” en salud, cosa que le permitirá en el futuro tomar decisiones compartidas con su médico. Se trata de un cambio

profundo en la relación terapéutica que incluye lo que se denomina actualmente la *alfabetización* y el *empoderamiento* en salud. Merece la pena dedicarle unas líneas a estos dos términos:

-Un paciente *alfabetizado en salud* es aquel que tiene la motivación suficiente para obtener, entender, evaluar y aplicar un contenido informativo fiable sobre la salud y los servicios sanitarios, de manera que pueda servirle para prevenir la enfermedad y mejorar sus condiciones de salud.

-Un paciente *empoderado en salud* es aquel que ha obtenido un control sobre sus decisiones y acciones relacionadas con la salud, siendo capaz de expresar sus necesidades y de movilizarse para obtener los correspondientes beneficios (saludables), tanto para sí como para su comunidad (p. ej. puede integrarse en una asociación de pacientes que tengan su misma patología y solicitar más recursos económicos para investigar sobre la enfermedad que padece).

Mientras la *alfabetización* implica obtener el conocimiento, el *empoderamiento* se conecta con la autogestión, pero ambas requieren como base una información veraz. Se añade que un paciente (bien) informado puede ayudar a su médico; esto no quiere decir que el primero deba tener más conocimientos que el segundo o que tenga que competir con él para ver quién sabe más. Tampoco indica que el paciente sea un "minimédico", sino simplemente que va a ser un compañero eficaz en la relación terapéutica. Como vemos, se obtienen notables ventajas, pues el paciente que reúna estas condiciones podrá cumplir mejor con las pautas de la medicación que tiene prescrita, gestionar las visitas médicas, comprender las instrucciones del alta hospitalaria, seguir indicaciones preventivas, comprender los índices de riesgo, etc.

**3.3.2. Momento operativo**. Se refiere a la actividad del médico que, obviamente, tiene que ser terapéutica o higiénico-terapéutica. Hablamos de las acciones encaminadas a la mejoría del cuadro clínico e incluyen desde el saludo inicial hasta el final de la relación. Incluye elementos de notable interés, como es:

-Por parte del médico, la escucha empática o comprensiva, en la que el paciente se apercibe de que el médico se ha tomado en serio su caso y lo ha escuchado y entendido.

-Por parte de médico y paciente, el diálogo interactivo que posibilita la captación de los síntomas, el diagnóstico y la prescripción terapéutica. Ya vimos este aspecto en las características generales de la relación clínica (epígrafe 3.2).

-Por parte del paciente, se requiere la aceptación de las pruebas diagnósticas y maniobras terapéuticas, muchas de las cuáles requieren la firma de un Consentimiento Informado.

**3.3.3. Momento afectivo.** La relación clínica también es un encuentro humano, lo que significa que se despliegan la afectividad del paciente y del médico. En principio se trata de crear una relación cordial, en la que se produzca una concordancia de objetivos dirigidos al manejo y, si es posible, la solución de la enfermedad. Ello implica la aparición de la "complicidad", que requiere la creación de un "sentido común"; esto mismo se muestra en demás relaciones humanas, las cuáles tienen más posibilidades de perdurar si existe este soporte. Recordemos que la creación de un "sentido en común", como efecto de la comunicación humana, ha sido una de las aportaciones más importantes de la Escuela de Palo Alto (ver Capítulo 1º).

Al mismo tiempo, en la interacción clínica se generan vínculos afectivos automáticos o no conscientes, sobre todo si la relación es prolongada. Estos tienen que ver, en numerosas ocasiones, con las relaciones familiares arcaicas del propio paciente, como le ocurrió a una paciente nuestra:

> *Mujer de 22 años, requiere constantemente en la terapia ser comprendida pero, sobre todo, que se le diga qué tiene que hacer en cada momento: "¿me presento al examen?", "¿qué temas cree usted que debería estudiar de todo este programa?", "mi novio me ha dicho que él quiere salir con sus amigos porque está muy encerrado en la pareja, ¿debo permitírselo?", etc. Estas solicitudes, en ciertos momentos en los que se encuentra más angustiada, se transforman en verdadera exigencia (transferencia) y se expresa con claridad: "no me dice nada", "debería decirme lo que piensa", etc. Indagando un poco en su biografía se descubre su grandísima dependencia familiar y la necesidad de que los padres le dieran una respuesta rápida que solucionara sus problemas.*

El médico también responde con su propia afectividad a los sentimientos de los pacientes (p. ej. no quiere atenderlo, se enfada, reacciona dándole órdenes, etc.). De momento dejamos este aspecto aquí para retomarlo cuando estudiemos la entrevista clínica.

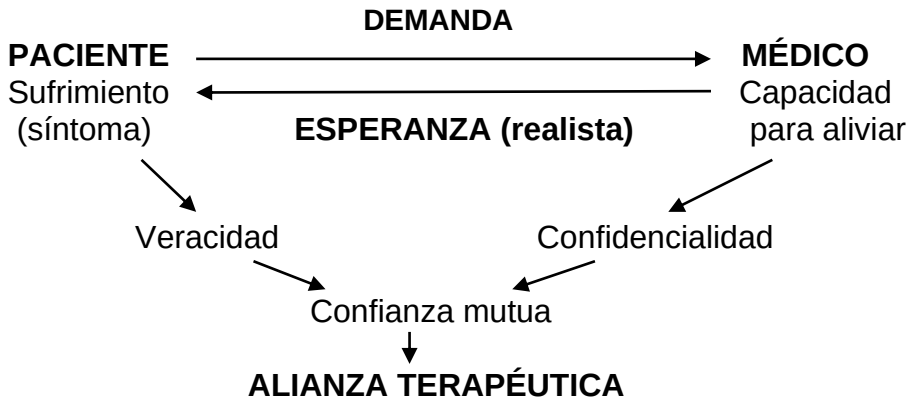
Al mismo tiempo, el médico es el depositario de los aspectos más íntimos del paciente relacionados con la enfermedad (hábitos, comportamientos de riesgo, adicciones, etc.); para que los exteriorice hace falta un clima afectivo que lo posibilite, de manera que deposite la confianza en el médico. Si esto se lleva a cabo, el paciente dota al profesional de la Medicina de una fidelidad y discreción absolutas (sea o no fiable).

**3.3.4. Momento ético (o social)**. La ética reflexiona sobre los problemas morales y, en concreto, sobre el asunto de los valores; estos últimos determinan cuando una conducta es correcta y cuando no lo es. No tiene nada que ver con cuándo una conducta es deseable o no, ya que puede ser deseable e incorrecta. A nivel individual, estas cuestiones se sostienen en las enseñanzas recibidas en

el medio familiar durante el proceso de educación infantil y luego matizadas en la escuela y en los grupos de pertenencia (aunque de forma un poco más correcta habría que decir que es al contrario: estos se escogen de acuerdo con los valores). De ahí se sigue que los valores morales no tienen el carácter de uniformidad, ni de universalidad. Lo cierto la personalidad tiene que tenerlos para saber cómo regirse o contar con una brújula sobre los comportamientos; si no se poseen, se corre el riesgo de ser rechazado socialmente.

Los valores que aquí interesan son los profesionales que, como su nombre indica, son los vinculados al ejercicio de una profesión, en este caso la Medicina, y ponen de manifiesto cómo debe comportarse un médico. Si este cumple con los valores, se dice que el médico es íntegro y le otorgan una autoridad moral, de la que se deriva la confianza del paciente y de la sociedad en general (5). Los valores a desarrollar en la relación clínica son los siguientes:

a) Confidencialidad. Implica no contar en otros contextos lo expuesto por el paciente en el consultorio; únicamente podría infligirse si existen riesgos o daños graves para terceros o para la población. La confidencialidad se complementa con la "veracidad", término con el que se indica que el paciente tiene que contar lo que honestamente cree que ha sucedido en relación a la enfermedad, a sus conductas relacionadas con la misma o a su situación particular. Con ambos (confidencialidad y veracidad) se consigue la confianza mutua, base de la *alianza terapéutica*, tal como puede contemplarse en el siguiente grafo:




La *alianza terapéutica* implica un contrato con el enfermo que, aunque no se encuentre escrito, se relaciona con la aceptación por parte de aquel de un conjunto de pautas de sobra conocidas y que, en la actualidad, se configura como una panoplia de actuaciones: acudir a las visitas programadas, realizarse las pruebas diagnósticas pertinentes, ejecutar el tratamiento, llevar a cabo medidas higiénicas, respetar horarios, etc. En definitiva, lo que se busca el compromiso del paciente en todo el proceso asistencial, pero hay que entender que no se trata de una imposición normativa, sino de un deseo: de sanar. Por lo tanto, lo que moviliza a hacer la demanda al sistema sanitario es este último y, sobre la base de la confianza mutua, se establezca la alianza terapéutica.

b) Justicia. Significa que todos los pacientes tienen las mismas oportunidades de atención médica. La Declaración de Ginebra (de septiembre de 1948) da respuesta a este asunto; se trata de una propuesta por la Asamblea General de la Asociación Médica Mundial (AMM), supone una actualización del juramento hipocrático, adecuándolo a los avances científicos y sociales modernos, e intenta crear una base moral para todos los médicos. Es una respuesta a las atrocidades que se cometieron en la Segunda Guerra Mundial y, respecto al punto que estamos estudiando, dice textualmente: "no permitiré que consideraciones de edad, enfermedad o incapacidad, credo, origen étnico, sexo, nacionalidad, afiliación política, raza, orientación sexual, clase social o cualquier otro factor se interponga entre mis deberes y mi paciente".

c) Autonomía. Expresa con claridad que no se deben tomar decisiones por el paciente, un fenómeno que en la antigua Medicina de corte autoritario era lo habitual. Solo puede hacerse cuando la vida del paciente corre un peligro extremo o la comunidad puede verse afectada por su enfermedad. No está permitido hacerlo en condiciones de "normalidad", aunque la respuesta sea obvia (p. ej. ante la pregunta del paciente si se divorcia, cambia de trabajo o de profesión, etc.); si se puede ayudar al paciente a que tome las decisiones por sí mismo y la psicoterapia resulta muy eficaz en este sentido.

d) No maledicencia. Significa no dañarlo o someterlo a riesgos innecesarios. Este asunto puede presentarse de forma bastante sutil ya que, en ocasiones, se prescriben ciertos fármacos en interés del propio médico, a sabiendas de que no son tan efectivos como otros ya conocidos, pero son nuevos y se desea probar su eficacia, sacar a la luz alguna publicación para engrosar el *curriculum,* atraer la atención de los colegas, etc. Tales intereses contravienen expresamente el principio del que ahora hablamos.

e) Beneficencia. Significa buscar el bien del paciente, no el propio. Entonces surge la siguiente pregunta: ¿qué saca el médico de su trabajo? La respuesta es que puede obtener solamente tres beneficios:

e.1) el sentimiento de haber ayudado a alguien que lo necesitaba y que ha mejorado con el servicio prestado.

> *Este es el caso de una paciente de 37 años de edad que acude a la consulta por un conflicto matrimonial que "tiene ya varios años de evolución". El marido es camionero y, cuando llega a la casa, sin asearse, sin ducharse se va hacia ella y la echa en la cama y, a continuación, mantiene una relación sexual a la que ella "no puede negarse". Tras el desarrollo de cierto número de sesiones, es capaz de decirle a su marido "no" y con esta simple partícula de negación se ha "convertido en una persona". El marido está bastante sorprendido pues ella jamás "se le enfrentó de esta forma" y viene a preguntar a la consulta qué se está*

*haciendo con ella, porque "ya no es la misma". Evidentemente, esta reacción espontánea de la paciente, que se repite a lo largo del tiempo, supone para ella una gran mejoría lo que, objetivamente, es así. Esta nueva reacción, provoca en el profesional que la atiende la sensación inigualable de que la terapia le está sirviendo ya que ha cambiado de posición.*

e.2) La obtención de nuevos conocimientos con cada caso atendido. Así, un psiquiatra sabe cada día un poco más sobre la depresión o sobre la esquizofrenia, tratándose de un conocimiento que, muchas veces, no queda reflejado en un libro porque son circunstancias muy precisas. Eso no quiere decir que un día el médico pueda saberlo todo, entre otras cosas porque el conocimiento humano es asintótico, lo que indica que tiene límites infranqueables. Fue justamente esto lo que hizo que Descartes dejara escrito: "daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro".

e.3) Finalmente, los médicos percibimos por nuestro trabajo un sueldo como remuneración al esfuerzo realizado; ello significa que no trabajamos por caridad, ni siquiera por compasión, sino que aplicamos los conocimientos adquiridos a lo largo de nuestra formación a los casos que se nos presentan. Este jornal se percibe dependiendo del contexto laboral en el que el médico realiza su labor, pudiendo abonarlo el paciente directamente (ejercicio privado de la Medicina) o bien, la institución a la que pertenece (ejercicio público de la Medicina).

Fuera de estos tres beneficios del médico, cualquier otra recompensa no está permitida (p. ej. participar en fiestas que el paciente organice, viajar en el barco de éste, obtener un cargo a través de él, etc.). Un apartado bien distinto son los regalos; en principio, no hay inconveniente en recibirlos, siempre que no entre en contradicción con los familiares (p. ej. una propiedad familiar) y no se trate de dinero en metálico (p. ej. un sobre con 2000 euros), ya que se percibe una cantidad (la estipulada) por el trabajo realizado.

### 3.4. Distorsiones de la relación clínica.

En este último apartado del capítulo se tratan los sesgos que pueden aparecer en la relación clínica y que hay que evitar para que esta sea auténtica; de ahí la importancia que tienen estas distorsiones en la comunicación. Vamos a estudiar las siguientes:

a) Existe la posibilidad de contemplar dicha relación sin cambios (*visión estática*). La enfermedad siempre se encuentra sometida a cambios, tanto físicos (empeoramiento, mejoría, estabilización clínica, etc.) como psicológicos. Este último elemento a considerar muestra una variabilidad extraordinaria, de manera que un mismo enfermo no acepta siempre de igual forma la propia enfermedad (a

veces la rechaza, otras la soporta, puede rebelarse, presenta una tolerancia forzada, etc.). En consecuencia, si el organismo, el sujeto o las circunstancias externas (apoyo familiar, separación matrimonial, cambio de residencia, hospitalización, etc.) cambian, la relación clínica también.

b) No contemplar las particularidades del paciente (*visión homogénea*). Significa que para el médico todos los pacientes son iguales y todos reaccionan de la misma manera frente patologías semejantes. Nada más lejos de la verdad, ya que un tumor maligno es vivido de forma diferente por cada persona considerada; este fenómeno, al que llamamos "efecto subjetividad" (cada "subjetividad" matiza o determina la forma de vivir la enfermedad) lo hemos comprobado con toda claridad en el cáncer de mama (6).

c) El médico es el único responsable del proceso del paciente (*visión reduccionista*). En el modelo de salud antiguo era el médico el que actuaba y respondía ante el paciente, valorándose si se equivocaba o actuaba certeramente; en la actualidad esta premisa resulta completamente obsoleta, desde el punto y hora en que el paciente tiene que ser activo en su proceso diagnóstico y curativo, debiendo: buscar información y procesarla adecuadamente (*alfabetización*), decir lo que necesita y tomar decisiones (*empoderamiento*). En una palabra: no puede estar al margen a su patología, como si no le concerniese, y, en este sentido, se comparte la responsabilidad. Desde este punto de vista, el paciente tiene en su mano participar o no participar en su salud, como puede verse en el siguiente ejemplo:

> *Un paciente de 83 años acude a la consulta para lograr "la fuerza suficiente para enfrentarse a su familia ya que, a pesar de haber sido diagnosticado de cáncer de pulmón, no quiere que lo operen y, mucho menos, seguir un tratamiento de quimioterapia". No tiene ningún síntoma psicopatológico, ni está loco, por lo que su decisión es consciente: "yo duraré lo que dure, no quiero que se ensañen conmigo y me hagan pruebas, me mutilen o me dejen extenuado con los potingues que utilizan". Por su lado, al oncólogo no le ha quedado más remedio que ceder ante la decisión del paciente; eso sí, le ha hecho firmar los correspondientes papeles, con lo que la responsabilidad de su evolución es exclusivamente de aquel.*

d) También es posible que el afán de la relación clínica sea devolver a la persona a sus obligaciones (*visión social*). Se trata de un fin utilitarista de la medicina, donde el papel del médico es recomponer la maquinaria y una vez logrado este afán, el sujeto vuelve a la comunidad para trabajar y producir.

e) La comunicación se centra en las pruebas y los resultados de las mismas (*visión instrumental*). El médico está volcado en el material objetivo sobre el enfermo y este se halla en las pruebas diagnósticas (biopsia, ecografía, radiografía, analíticas, TAC, RNM, etc.), al tiempo que descarta la parte humana

de quién acude a su consulta. Esto provoca la frustración del paciente, que contempla como el médico no lo entiende, ni se preocupa por su malestar, llegando a un distanciamiento de aquel.

Actualmente, asistimos a un notable auge de las llamadas “medicinas alternativas” como nunca se ha conocido antes. Una posible explicación se encuentra en la deshumanización actual de la Medicina, de manera que un homeópata, un naturópata o, incluso, un curandero o sanador acompaña más al paciente que el propio médico durante el tránsito por la enfermedad (7). Se trata de un efecto verdaderamente lamentable, asociado a la evolución tecnifica de la Medicina, que llega a despreciar a la persona en aras de lograr un ejercicio “verdaderamente científico”.

**BIBLIOGRAFÍA.**

1. Millán J, González P (coords.). Educación médica centrada en el paciente. Madrid: Unión Editorial, 2017.
2. Eliade M. El chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis. México: FCE, 2009.
3. Lain Entralgo P. El médico y el enfermo. Madrid: Guadarrama, 1969.
4. Laín Entralgo P. La relación médico-enfermo. Historia y teoría. Madrid: Revista de Occidente, 1964.
5. Millán J. Valores del médico para un ejercicio de calidad: el profesionalismo. Revista de la Fundación Educación Médica 2014; 17 (supl. I).
6. García Arroyo JM. El cáncer de mama (1): reacciones ante el diagnóstico. Ediciones Dis & Capaz, 2011.
7. García Arroyo JM. Seminario sobre Magia y Medicina. Asociación de Psicopatología y Psicoanálisis de Sevilla, 2018.

## Capítulo 4º. Los Modelos Asistenciales: centrado en el médico, en el paciente, en la mutua colaboración y en la sociedad.

### 4.1. Los modelos asistenciales y su clasificación.

Un *Modelo Asistencial* puede considerarse la base de la relación clínica y pronto entenderemos por qué. Un modelo no es la realidad misma, sino una representación conceptual de la misma, que procura captarla de alguna manera para describirla y entender cómo es. Dado que cualquier realidad (física, química, social, etc.) es compleja, jamás podrá ser abarcada de modo completo, de ahí que existan diferentes modelos que procuran acercársele, siendo todos ellos parciales. Al mismo tiempo, cualquier modelo resultará siempre menos complejo que la realidad a la que intenta aproximarse, al ser una perspectiva de la misma. Estas directrices se hacen más patentes en el momento en que la aproximación se hace al ser humano, dado que este es el objeto más complejo que existe.

Lo que hemos dicho para los modelos en general puede calcarse punto por punto a la relación clínica. En ella, los modelos asistenciales resultan fundamentales para saber cómo interaccionan estos dos personajes.

Agrupamos los modelos asistenciales en cuatro tipos, según el aspecto que se tiene en cuenta:

1. Los roles de los participantes.

2. El tipo de participación.

3. El objetivo de la relación.

4. El grado de control.

Como se verá a continuación, cualquiera de ellos puede hacernos reflexionar sobre la práctica médica.

**4.1.1. El modelo de los roles**. Estudiamos aquí el llamado *Modelo de Parsons* de gran relieve dentro de la Medicina (1); es un poco antiguo pero sigue funcionando y aportando datos. Talcott Parsons fue un sociólogo norteamericano, afincado en la Universidad de Harvard y una de las figuras más influyentes en el desarrollo de la Sociología en el siglo pasado.

Esta forma de aproximarse a la relación clínica se sostiene en los comportamientos esperados y en los privilegios sociales asociados a cada uno de los roles de los participantes: el médico y el paciente. En la siguiente tabla se establecen cuáles son las características de cada uno de ellos:

| MÉDICO | ENFERMO |
|---|---|
| Adquirido | Involuntario |
| Universalista | **Temporal** |
| Competencia técnica | Buscar ayuda técnica |
| Afectividad neutral | Desear la curación |
| Beneficio del paciente | Confiar en el médico |
| Acceso a la intimidad del paciente | **Exento de responsabilidad** |
| Autónomo - Dominante | **Dependiente - Sumiso** |

Como puede comprobarse, Parsons plantea una serie de características diferenciales para cada uno de estos dos papeles. De ellas, hemos señalado en negrilla tres por ser fundamentales (temporalidad, exención de responsabilidad y dependencia), pues ponen de manifiesto cómo, ante la enfermedad, se produce una *regresión*, de tal modo que se busca el apoyo y la asistencia de los demás (dependencia) junto a dejar la carga social que se estaba llevando (trabajo, ocupación, etc.). Además, estas particularidades explican muy bien cómo muchos pacientes, una vez que se han curado de la enfermedad, continúan presentando síntomas y el *Modelo de Parsons* pone de manifiesto cómo estas personas buscan:

-la ausencia de responsabilidad (se encuentran exentas de tener culpa alguna por estar enfermas),

-no cumplir con las obligaciones habituales (no tienen que ir a la Facultad, examinarse o atender a su actividad laboral),

-dependencia (buscan a otros en los que apoyarse) y

-cierta continuidad (el estado se prolonga en el tiempo).

Ponen en marcha una *regresión patológica*, un estado en el que se ubican obteniendo beneficios secundarios con los síntomas y adoptando la "enfermedad" un carácter permanente. Para tales casos se ha acuñado el término de *neurosis de renta*, entonces el médico descubre una desproporción entre los síntomas que el paciente presenta y los hallazgos clínicos, al tiempo que los tratamientos específicos no producen efectos terapéuticos. No se trata de simuladores, ya que tales efectos contienen claras motivaciones inconscientes (p. ej. buscar cariño o atención, miedo a la responsabilidad, insatisfacción laboral, eludir un ascenso, etc.).

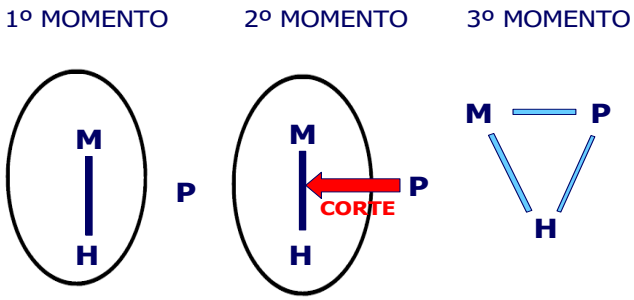
Los simuladores pueden poner de manifestó en la consulta los mismos síntomas pero existe una motivación consciente que, aunque no la confiesen, se encuentra (p. ej. obtener la nacionalidad española, quedarse con la custodia de los hijos, eludir un juicio, buscar una indemnización o una pensión, etc.). Aquí, el paciente intenta engañar a su médico y para ello exagera los síntomas (actitud fraudulenta), mientras que en la *neurosis de renta*, en todo caso, el sujeto se engaña a sí mismo (deseo inconsciente de estar enfermo).

La 10ª Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedad (CIE-10), en su apartado de Trastornos Mentales y del Comportamiento (2), separa con toda claridad estos dos cuadros: la *neurosis de renta* en el capítulo F.68 ("Elaboración psicológica de síntomas somáticos") y la *simulación* en el Z.76.5 ("Enfermos fingidos –simuladores conscientes-").

**4.1.2. El modelo de participación.** Aquí tenemos que considerar el *Modelo de Hollender y Szasz* (3), en el que se tienen en cuenta el grado de actividad y participación de médico y paciente en la interacción. El comportamiento del médico y del paciente están condicionados por el tipo de enfermedad y del momento evolutivo de la misma. En la siguiente tabla se detallan estos extremos:

| **MÉDICO** | **PACIENTE** | **PROTOTIPO** | **SITUACIÓN** |
|---|---|---|---|
| Actividad | Pasividad | Madre-Lactante | Urgencias, coma, cirugía. |
| Guía | Cooperación | Padre-Hijo | Enfermedad aguda, procesos infecciosos. |
| Participación | mutua | Adulto-Adulto | Enfermedades crónicas, tratamientos prolongados. |

Para entender bien el esquema que plantean estos autores hay que saber cuáles son los papeles de la madre y del padre. Para ello, hay que tener en cuenta, antes que nada, que no estamos hablando de las personas que engendraron al crío, sino de "funciones" que pueden ser desempeñadas por otros personajes de la familia (abuelo/a, hermano mayor, tío/a, etc.). Existe un primer momento en el que el bebé está unido a la madre formando una especie de huevo, en el que no cabe el padre; así las cosas, la *función materna* implica atender a un ser que se encuentra indefenso y que, sin los oportunos cuidados, no es capaz de sobrevivir; mientras tanto, el padre se encuentra periférico a esta unión. En un segundo momento, el padre interviene realizando la función de *corte* o de separación de la diada madre-hijo. En otro tercero, se forma un triángulo en el que existen dos funciones bien definidas: la del padre y la de la madre, que el hijo identifica perfectamente.




En la primera posición del modelo encontramos un médico activo y un enfermo pasivo, de manera que el prototipo de relación que se establece es *madre-lactante*. Esta forma de participar tiene lugar en los servicios de urgencias, estados de coma o en intervenciones quirúrgicas, donde el paciente no puede responder y es llevado por el médico, quién dispone libremente de su estado. En la segunda, el médico participa como guía y el paciente coopera, de forma tal que este último realiza las indicaciones que le dicta el primero; una prototipo de relación *padre-hijo* que puede presentarse en los procesos agudos. Finalmente, en una tercera posición la relación que se establece es de *adulto-adulto* y se da en las enfermedades crónicas que, como se ha dicho antes, son las predominantes hoy en día.

Véase como las dos primeras posiciones son regresivas (la que más la primera), mientras que la última es progresiva, lo que posibilita la creación de acuerdos entre médico y paciente, cosa que es imposible en las anteriores. Se añade que, si el paciente mejora de su dolencia (p. ej. sale de la intervención o de la UCI), tiene que cambiar de actitud para ser más activo ya que es pernicioso para su curación acomodarse en la pasividad (movimiento progresivo).

**4.1.3. El modelo basado en el objetivo de la relación.** En este apartado hay que considerar el *Modelo de Tatossian*. Este autor distingue dos niveles de relación:

-Interpersonal humano. El paciente es contemplado en su globalidad (cuerpo-subjetividad) y el trastorno forma parte de él en tanto sujeto que es. La relación que se establece es de persona-persona, con lo que existe una implicación humana del médico en el proceso asistencial. Se indica este modo de actuación en todas las especialidades clínicas, incluida la cirugía.

-Técnico de servicio. Aquí la atención se centra de modo exclusivo en el órgano enfermo o en la parte del organismo afectada. El objetivo no es la

persona, sino una parte concreta; de hecho el médico no ve al paciente, solo las muestras o imágenes. Es aplicable a las especialidades no clínicas.

Este modelo pone en alerta al médico de una posibilidad nefasta: la de pasar del primer nivel (interpersonal) al segundo), convirtiéndose en un técnico. Esto le sucede a aquellos profesionales de la Medicina que solo desean contemplar al paciente como un organismo enfermo, evitando considerarlo como una persona que sufre y a quién hay que escuchar (deshumanización).

**4.1.4. Modelo basado en el grado de control**. En este caso se tienen en cuenta diferentes contextos en los que se puede aplicar el quehacer médico. El *grado de control* supone pensar quién es el que organiza o legisla sobre la RME, si el médico, el paciente, ambos o ninguno; ello provoca la aparición de distintas posibilidades tal como figuran en la siguiente tabla en la que se recoge quién toma las riendas:

| **MÉDICO** | **PACIENTE** | **MODELO** |
|---|---|---|
| Alto | Alto | Mutualista-NEGOCIADOR |
| Alto | Bajo | Paternalista-CUIDADOR |
| Bajo | Alto | Clientelista-PROVEEDOR |
| Bajo | Bajo | Deficitario-DESCONTROL |

Vamos a estudiarlos detenidamente:

-Modelo paternalista. Aquí el médico es quién controla y toma un papel de cuidador. Se trata de un profesional de la salud que se encuentra comprometido con el paciente y busca su beneficio, mientras este se encuentra exento de responsabilidades en la curación. Hasta ahora ha sido el modelo predominante, pero con el tiempo tiende a desaparecer.

-Modelo mutualista. En esta posibilidad el control de ambos es alto. El médico adopta el papel de negociador, lo que significa aportarle información y cualificación técnica al enfermo, al tiempo que se produce un diálogo de decisión. Para ello se instaura una colaboración en la que el paciente tiene voz y voto en todo el asunto, dejando de lado cualquier actitud pasiva. Las distintas compañías de salud incluyen este tipo de actuaciones.

-Modelo clientelista. El paciente controla la relación pues es consumidor de un servicio técnico. El médico actúa como proveedor de cuidados de salud, prescribiendo pruebas o tratamientos a demanda del paciente. Llevado al límite esta forma de actuar le lleva a ser exigente y caprichoso, a menudo descontento

con lo que se le da. Este fenómeno se observa muy bien en las clínicas de cirugía plástica, donde el consultante solicita una y otra vez intervenciones, que el médico tiene que realizar a demanda y tiene que darle lo que pide. Las clínicas privadas se ceban de este tipo de relación.

-Modelo deficitario. El control del paciente es bajo o ausente, pero tampoco el médico lleva las riendas de la relación (como en el modelo paternalista). Se produce una forma de actuar descontrolada, desorganizada, en la que el médico no asume su responsabilidad ni como cuidador, ni como proveedor. El paciente tampoco desempeña su rol, no responsabilizándose de su propia salud. La relación se convierte en caótica, paralizante y nada práctica. Se presenta comúnmente en clínicas de desintoxicación (dependientes de sustancias) y en las comunidades terapéuticas.

> *Estas últimas han sido una creación realizada a partir de la Reforma Psiquiátrica, que obligó a organizar de dispositivos que acogieran a los enfermos mentales, que antes se hallaban internados en los hospitales psiquiátricos. Algunas de ellas eran grandes casas o incluso chalets con piscina, donde cada enfermo hacía lo que quería (se bañaba, paseaba, tomaba el sol, leía, dormía, etc.). Los médicos no tenían un lugar diferenciado respecto a los pacientes (no usaban bata, ni distintivos especiales) e, incluso, la programación brillaba por su ausencia.*

### 4.2. La relación médico-paciente en los modelos asistenciales clásicos.

En este apartado se pretende conocer cómo ha ido evolucionando la RME a lo largo del tiempo desde una asistencia organizada en torno al médico, hasta otra bien distinta donde el paciente es el centro de la relación.

**4.2.1. El modelo médico**. Es el más antiguo y se centra exclusivamente en el plano biológico (por eso se le llama “modelo biomédico”). El médico toma el lugar de experto y su papel es realizar el diagnóstico. Implica que el paciente es un mero objeto en sus manos y existe en tanto presenta síntomas; si está asintomático, la relación no tiene ninguna función. En tal caso, el médico orienta su labor profesional a la recogida de signos y síntomas, mediante un interrogatorio dirigido. Al límite es un esquema centrado en el médico de manera que dispone a su antojo del paciente y este tiene que responder positivamente a sus indicaciones.

**4.2.2. El modelo biopsicosocial**. A finales de los años 70 y comienzo de los 80, G. Engel (4,5), psiquiatra norteamericano afincado en la Universidad de Rochester, realizó una crítica al *modelo biomédico* (predominante en esa época), proponiendo otro nuevo más holístico e integral. Este tenía en cuenta a la persona en su conjunto, ya que no era posible definir la enfermedad en términos estrictamente somáticos y adoptó el nombre de *modelo biopsicosocial* (BPS).

*Este cambio tiene su razón de ser porque, incluso, en el caso en el que esté clara la etiología de la alteración, no basta esta para definir y denominar a la enfermedad. Así, el diagnóstico de un paciente tuberculoso no solo debe decir: "tuberculosis", sino indicar que asienta en un sujeto alcohólico, indigente, aislado y sin familia, vive en la calle, que padece un deterioro cognitivo, etc. Por consiguiente, en la consideración de su patología intervienen múltiples factores.*

Por lo tanto, el modelo BPS surge como una corrección del modelo médico e incluye factores psicológicos, culturales y sociales del enfermar. Introduce la anamnesis de los datos psicosociales, estilos de personalidad y afectividad. En él el paciente adquiere nuevas dimensiones, ampliándose la RME, pero sigue organizado sobre el médico.

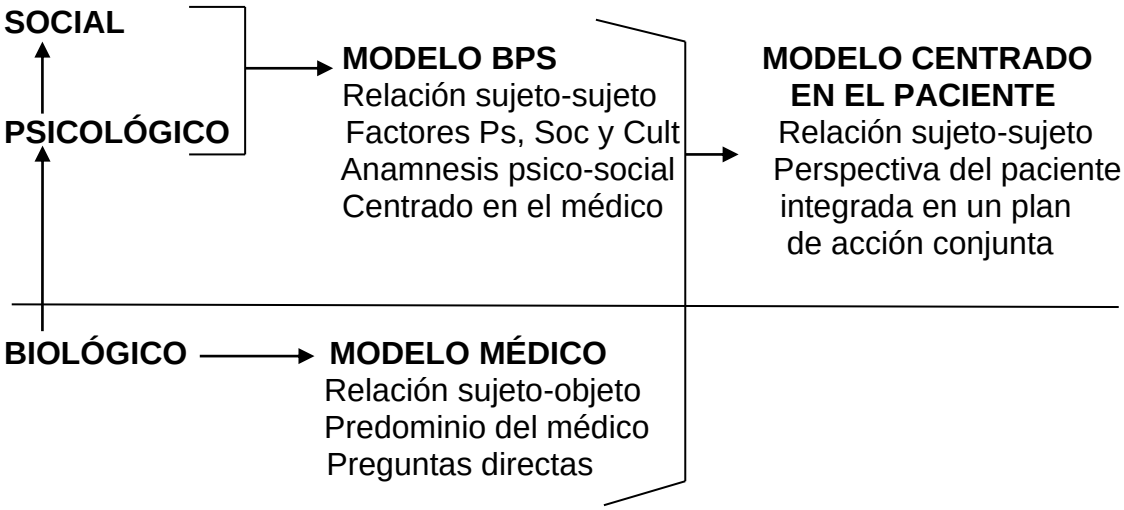
**4.2.3. Modelo centrado en el paciente**. En este último, el empeño se pone en comprender la perspectiva del paciente e integrarla en un plan de acción conjunto. Ya no tiene como meta última el diagnóstico, sino la prevención y la intervención solo es directiva cuando se trata de concretar los síntomas. Este planteamiento novedoso demuestra ser eficaz respecto al paciente en: la motivación a participar en el proceso terapéutico, la satisfacción de las intervenciones realizadas y la adherencia y cumplimiento del tratamiento.

La comunicación con el enfermo no es solo para transmitir un mensaje diagnóstico, sino que se convierte en un instrumento para que aquel realice conductas de prevención, sirviendo, además, como elemento de educación y promoción de la salud. Como cualquier modelo tiene sus limitaciones, ya que no es la panacea:

a) En tratamientos de larga duración deriva a una relación más directiva para subsistir. Téngase presente que el enfermo crónico tiene altibajos en relación a su patología, a veces la acepta y otras no, lo que conduce a inconstancias relacionadas con el cumplimiento terapéutico (tratamiento, analíticas, citas, etc.). De ahí que el médico tenga a veces que imponerse, con cierta delicadeza, para que el paciente cumpla; ampliaremos un poco más este asunto cuando veamos la *asertividad* en Medicina (capítulo 6º, apartado 6.3.).

b) No contempla los sentimientos de ruptura existencial, frecuentes en la enfermedad grave, donde se incluye el estado de desesperación que muchas veces embarga a estos enfermos. Tal es el caso del que no colabora con las propuestas terapéuticas que se le han propuesto o se deja morir (no comiendo, no bebiendo, no saliendo de la cama, etc.). Plantea el claro interrogante de: ¿entonces qué se hace? ¿habría que salirse del modelo para adoptar otro?

**NIVELES**




### 4.3. Interferencias en la relación médica.

Ahora estudiamos los inconvenientes que pueden producirse y que dificultan la RME, haciéndola inadecuada. Téngase presente que las diferentes cuestiones que se muestran a continuación pueden llevar a un desplazamiento (de los roles, de las actitudes, etc.) en los modelos anteriores. Así, si un sistema de salud se encuentra demasiado masificado (como ocurre actualmente), en el *Modelo de Tatossian* se produce un movimiento desde el nivel *interpersonal* al *técnico*, ya que el médico tiene que atender de manera exclusiva a los síntomas al no tener tiempo para afinar el trato con el paciente. Al mismo tiempo, ante ese desbarajuste, el médico procura tomar el control de la situación, haciéndose más autoritario, iniciando un deslizamiento sutil hacia una posición paternalista.

#### 4.3.1. Los aspectos cognitivos.

-Puede ocurrir que el problema del paciente no sea captado globalmente y que se empleen únicamente soluciones técnicas. Esta actuación, ya contemplada en el *Modelo de Tatossian*, implica eliminar los aspectos humanos de la relación y dedicarse únicamente al organismo.

-El paciente posee esquemas cognitivos distorsionados y el médico no es capaz de captarlos. En muchas ocasiones, el pensamiento que tiene es mágico y las soluciones que se buscan son de esta índole (p. ej. espera un milagro con el tratamiento prescrito) o se encuentra depresivo y no desea curarse (p. ej. acude a tratarse por petición expresa de la familia, pero no va a tomarse la medicación que se le prescriba).

-La comunicación es aparente, lo que significa que los mensajes no son sinceros. Aparecen mentiras que el consultante despliega para conseguir sus propios fines (p. ej. obtener una baja laboral).

### 4.3.2. Los aspectos afectivos.

**a) Relativos al médico.**

-La excesiva proyección sobre los pacientes. El médico coloca aspectos psicológicos suyos, considerados negativos, en las personas que atiende.

> *Un médico residente que acudía a la consulta siempre ha tenido problemas de pareja y en su historia existen finales de relación bastante problemáticos, que se han producido tras dudas importantes sobre si terminar o no. Al ser una persona muy dependiente, la separación se complicaba aunque sabía perfectamente que tenía que hacerlo. Pues bien, en su consulta, con todos los enfermos que presentaban conflictos de pareja, siempre actuaba presionándolos para que se separaran, cosa que algunas veces lograba. Este afán estaba motivado por sus problemas personales y es como si dijera: "yo no puedo separarme, pero ellos sí lo van a hacer con mi ayuda". Como cabe entender, actuaba poniendo en los pacientes aspectos suyos y realizándose a través de ellos.*

–La búsqueda de intereses propios. Se trata de un aspecto del que se habló al principio de este capítulo: el *narcisismo médico*, que aquí toma la forma de afán de lucro o fama. El paciente se da cuenta de lo que está buscando. Llevado más allá puede tomar la forma de una autovaloración excluyente, donde él es el mejor y los demás no valen nada.

-La agresividad o arrogancia defensiva. Puede suceder que el médico se encuentre inseguro de sus actuaciones y reaccione de manera arrogante, creando una distancia excesiva con el paciente, dando lugar a una relación fría y carente de empatía.

-El rechazo de la responsabilización. También es posible que el médico culpe de todo lo que pase en la RME a quién le consulta, no viendo en sí mismo los problemas que ocasiona por sus propios rasgos de la personalidad. Con un ejemplo puede quedar más claro:

> *Un médico de familia que acude a la consulta a realizar psicoterapia es muy exigente con sus pacientes (puntualidad, realización del tratamiento de modo exacto, citas, etc.). Cuando estos no cumplen los amonesta y, evidentemente, acaban enfadándose. Entonces, no ve lo rígido que puede llegar a ser con los enfermos y piensa que son "malos" o "insoportables", sin la capacidad de ver lo que él pone en la relación.*

-La rigidez es otro aspecto que interfiere en la RME. En este caso, el médico actúa de manera demasiado racional ateniéndose a todos los protocolos existentes, sin salirse ni un milímetro de los mismos, optando por lo que llamamos *visión homogénea* en la que no existen diferencias entre sus pacientes. En

consecuencia, no es capaz de captar las particularidades afectivas de cada uno de ellos (p. ej. no todas las pacientes que tienen cáncer de mama aceptan la quimioterapia, debido a cuestiones personales de cada una de ellas).

**b) Relativos al paciente.**

-Las reacciones emocionales adversas. Puede ser inducidas por otros pacientes o familiares o por experiencias negativas anteriores con médicos; en cualquier caso, cuando el enfermo presenta este tipo de respuestas previas al contacto con el médico, dificulta notablemente la relación con este, sobre todo si no está acostumbrado a este tipo de fenómenos.

-Estados afectivos intensos. Manifestaciones afectivas como la ansiedad, la depresión o la ira puede interferir en el contacto, dado que el paciente se muestra muy alterado y es incapaz de aportar una información ordenada sobre su proceso, al tiempo que se producen reacciones emocionales de distinto calado en la consulta.

-Miedo a una enfermedad grave o desconocida. También aquí existen respuestas emocionales que perturban la buena marcha de la entrevista clínica. En estos tres últimos supuestos se encuentran las emociones en un primer plano, en los próximos capítulos daremos cuenta de cómo pueden manejarse adecuadamente en la consulta.

-La desconfianza. Existen pacientes desconfiados por su propia estructura psicológica, los llamamos *paranoides*; algunos de ellos pueden incluso interponer quejas, reclamaciones y pleitos a los médicos, son los *querulantes*. Pero, también el profesional de la medicina puede atender a sujetos que dan vueltas por el sistema sanitario sin obtener soluciones; esta situación es frecuente en el caso de los “trastornos somatomorfos” (2), entre los que se incluyen los hipocondríacos y aquellos que presentan dolor sin una causa justificada. La desconfianza de estos últimos es secundaria a no obtener respuestas por parte del sistema sanitario; podemos decir que van “con la escopeta cargada” a la consulta.

-La excesiva exigencia tiene que ver con pacientes que piden demasiado de la consulta médica, lo cual se pone de manifiesto en un verdadero abanico de posibilidades sobre: la realización de pruebas, la celeridad de los resultados, el tratamiento que desean, la cura rápida de la enfermedad, la ausencia de efectos secundarios, etc. En ellos es común la queja, pudiendo llegar a solicitar numerosas consultas no programadas, cuando no a reclamaciones.

**4.3.3. Los aspectos sociales.** En este apartado se analizan aquellos inconvenientes que se refieren al contexto comunicativo; son los siguientes:

-La masificación. El aumento del número de pacientes por jornada laboral del médico es un problema importante al reducir el tiempo de dedicación a cada

uno de ellos. En tal caso, quién consulta se siente desatendido ya que el contacto con su médico ha sido un acto protocolario y ni siquiera ha rozado sus expectativas. Pero, el médico también se ve implicado porque realiza las consultas mecánicamente, produciéndole la sensación de que algo importante puede escapársele.

-La burocratización. Implica que, cualquier acto médico, tiene que figurar en un registro o contar con un informe de su autoría. Ello implica el gasto de un tiempo que no tiene y le produce la sensación de no poderlo dedicar a atender a sus enfermos. Hoy en día para cualquier cosa se solicita un informe (accidentes de tráfico y laborales, cuestiones legales, petición de subsidio, separación matrimonial, etc.) y el médico se ve implicado sin poder delegar en nadie.

-La asistencia despersonalizada. Puede tratarse de una consecuencia lógica de los dos aspectos anteriores o bien, tiene que ver con la personalidad del médico, que evita el contacto afectivo con las personas que atiende. Sea como fuere, el paciente se siente tratado como un objeto y sin atreverse a expresar su sufrimiento delante del médico.

-Desconocimiento de los valores culturales. Ciertamente una posibilidad es que el médico vaya a trabajar a un lugar donde no conoce las tradiciones o los preceptos de esa comunidad. Entonces, puede meter la pata al dar pautas o medidas que vayan en contra de aquellos. Veamos un ejemplo:

> *Un médico, que acude a consultar, tomó su plaza en un pueblo de la Comunidad de Extremadura. Es un gran aficionado al psicoanálisis, pero no ha entendido ni una sola palabra de esta materia. Un día le tocó atender a una joven viuda aquejada de síntomas histéricos (sobre todo alteraciones de la marcha). El buen doctor rápidamente se dió cuenta del origen de los síntomas y le dice a la paciente que le haga un croquis de su casa, cosa que ella solícitamente realiza. Entonces, le indica que arregle una estancia de su casa y que se busque un amante con el que tener encuentros amorosos en ese lugar. La paciente salió espantada, llegando a ponerle una denuncia por "falta de respeto a su persona y por abuso de autoridad". El médico no había entendido ni lo que es la histeria, ni cómo tratarla pero, más que nada, había dado un consejo inadecuado a una persona, que iba claramente en contra de las costumbres de su pueblo.*

-Diferencias sociales. Cuando existen diferencias importantes respecto a la persona que se tiene delante, se precisa un esfuerzo extra para lograr que la comunicación sea efectiva. Ya se trate de una persona de otra clase social, etnia, país o grupo minoritario, el médico tiene la obligación de atenderlos en condiciones de igualdad (véase el "momento ético" en el capítulo anterior), de ahí que tenga que poner su empeño en lograr el contacto con ella, a pesar de las dificultades.

**BIBLIOGRAFÍA.**

1. Parsons T. El sistema social. Madrid: Alianza Universidad, 1984.
2. OMS. CIE-10. Trastornos Mentales y del Comportamiento. Madrid: Meditor, 1992.
3. Szasz TS, Hollender MH. A contribution to the philosophy of medicine: the basic models of doctor-patient relationship. Arch Intern Med 1956; 97: 585-592.
4. Engel G. The Need for a New Medical Model: a Challenge for Biomedicine. Science. 1977;196:129-36.
5. Engel G. The Clinical Application of the Biopsychosocial Model. Am J Psychiatry 1980;137:535-544.
6. García Arroyo JM. El cáncer de mama (1): reacciones ante el diagnóstico. Ediciones Dis & Capaz, 2011.

## Capítulo 5º. Desarrollo y aprendizaje de habilidades de comunicación (I). a) De contenido: la narrativa médica. b) Técnicas, herramientas y estrategias.

### 5.1. Importancia de las habilidades de comunicación en Medicina.

Entramos en un capítulo nuevo que responde a la cuestión de: ¿qué es lo que tiene que hacer el médico con sus pacientes para que la comunicación sea efectiva? La respuesta se encuentra en el desarrollo de habilidades de comunicación que, evidentemente, no conoce y que tiene que aprender e incorporar. Antiguamente estas no existían y, como consecuencia, no se enseñaban, de manera que el médico se contentaba con realizar las tres preguntas hipocráticas (¿qué le pasa?, ¿desde cuándo? y ¿a qué lo achaca?) y un interrogatorio posterior totalmente dirigido.

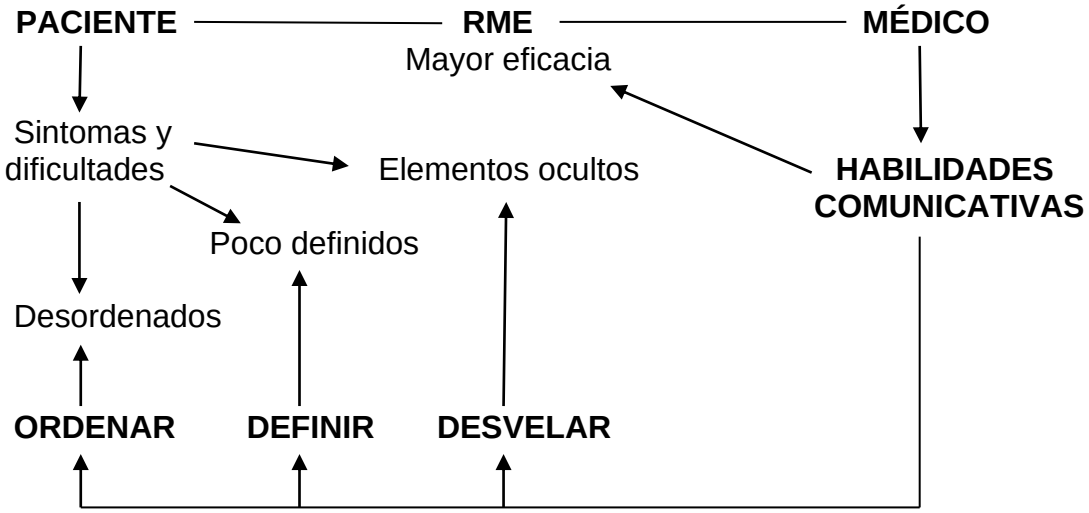
Una nueva pregunta puede introducirnos en materia: ¿por qué son tan importantes las habilidades de comunicación? Intentaremos responderla. Los pacientes traen a la consulta médica síntomas y también problemas, esto último es un efecto que se ha producido en los últimos tiempos. Cualquiera de ellos viene codificado en forma de palabras, presentándose de forma:

-desordenada, lo que implica que hay que organizarlos,

-poco definidos, lo que lleva a tener que concretarlos y

-con elementos ocultos, que hay que desvelar.

De ahí la importancia de las habilidades de comunicación, porque enseñan el camino para realizar estas tres acciones (organizar, concretar y desvelar). Se oponen al actuar impulsivamente y a la inmediatez, constituyéndose en estrategias de acción planificadas. El siguiente grafo es bastante demostrativo de lo expuesto:



Si esto se realiza bien, se consigue una mayor eficacia en la relación terapéutica, que se observa en que:

a) se obtiene más información relevante, con lo que puede comprenderse mejor el problema,

b) se produce la implicación del paciente en su enfermedad, con lo que acepta más las opciones de tratamiento y un mayor cumplimiento terapéutico; indica que se favorece el compromiso de aquel,

c) mayor satisfacción del paciente y

d) menor sensación de vulnerabilidad, con lo que se intenta evitar la aparición de síntomas ansiosos y/o depresivos.

Existen cuatro tipos de habilidades de comunicación que se estudiarán sucesivamente:

A. De contenido: la narrativa médica (capítulo 5º).

B. Procesuales: técnicas y herramientas (capítulo 5º).

C. Cognitivo emocionales: gestión emocional, empatía y asertividad (capítulo 6º).

D. De objeto: diagnóstico, pronóstico y tratamiento (capítulo 6º).

**5.2. Habilidades de contenido.**

**5.2.1. Concepto de narrativa.** Se trata de un género literario que engloba todo tipo de relatos: novela, cuento, fábula, etc. Cualquier relato presenta las siguientes características:

-Aparecen una serie de hechos, explicados por un narrador, que le suceden a uno o más personajes.

-Consta de una secuencia ordenada de sucesos, que conforma una historia. Esta secuencia resulta válida dentro de una cultura, lo cual es evidente ya que cada grupo humano tiene sus mitos y sus leyendas, que únicamente tienen sentido en el seno del mismo. A pesar de ello, existen historias que, con más o menos variaciones, se vienen repitiendo en diferentes ámbitos culturales pero, aún así, cambian los nombres, el contexto, ciertos datos, etc.

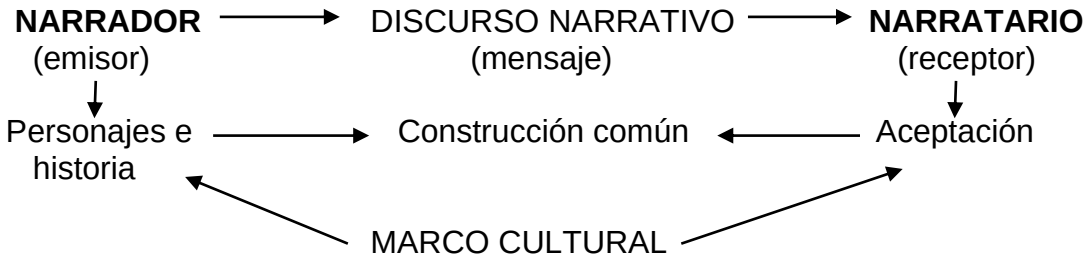
Si estudiamos en profundidad este fenómeno, podemos entenderlo como un proceso comunicativo, donde se distinguen:

-Un narrador, que es quién genera el acto comunicativo y crea tanto los personajes como lo que les ocurre (historia); actúa como emisor.

-Un narratario o personaje que lo acoge y valora; interviene como receptor.

-El discurso narrativo, que se constituye como mensaje.

-Se produce una construcción común; ciertamente, el narratario se queda prendado de la historia, la experimenta y la "vive". Recodemos cómo el Colegio Invisible se refirió a este fenómeno.




### 5.2.2. La *narrativa médica*.

**A. Origen.** Desarrollada en Estados Unidos, donde ha destacado la figura de Rita Charon (1), profesora de Medicina de la Universidad de Columbia. Ha tenido una repercusión comparable a la de la Medicina Basada en la Evidencia y, tanto es así, que se habla de *Medicina Basada en Narraciones*. Hoy en día se imparten numerosos cursos de formación dedicados a este asunto, teniendo una buena acogida entre los médicos.

La novedad que presenta la *narrativa médica*, como su nombre indica, es la utilización de relatos para descifrar el entramado humano. Aparece como una respuesta a la insatisfacción de la Medicina, que se ha mostrado insuficiente para captar adecuadamente las circunstancias en las que esta disciplina se desenvuelve, como son: trabajar con situaciones poco definidas, de incertidumbre y de conflicto (2), junto al abordaje de la experiencia íntima del paciente. En este sentido, la Medicina moderna cuenta con muy pocas herramientas para acceder al sufrimiento o a la desesperación, siendo tal vez la Psiquiatría la única especialidad en la que no se discute que hablar, escuchar y escribir resulta terapéutico (3).

Aporta una serie de cualidades altamente valoradas en el buen desempeño del quehacer médico:

1. La singularidad. Significa entender que, aunque la enfermedad es común y aparece de la misma forma en cualquier parte del planeta (con los mismos síntomas y signos), la persona que la padece es única. Dicho de otra forma: aunque dos individuos tengan la misma patología, la forma de vivirla de cada uno de ellos es personal.

2. La humildad. Indica saber que, aquello que el médico construye a partir del contacto con el paciente, no es la "verdad", antes al contrario debe tener en cuenta lo que otros profesionales han hallado en el mismo sujeto. Para considerar este asunto de la perspectiva particular de cada uno (*perspectivismo*), hay que ser humilde y no pensar que uno lo conoce todo, tanto como para tener "el saber absoluto". En consecuencia, mi compañero/a (con su propia narrativa) puede aportar datos en los que yo ni siquiera he reparado. Aceptar la perspectiva del otro en dialéctica con las mía no es un estorbo a eliminar, sino la única forma de describir la realidad clínica.

3. La responsabilidad. Se relaciona con atender e interpretar bien el caso que tengo entre manos, cosa que no puede realizarse en condiciones si no soy capaz de reconstruir el historial del paciente.

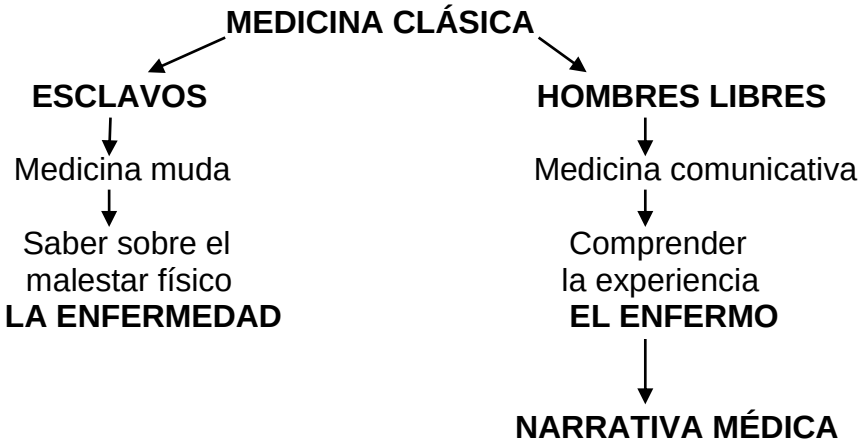
4. Empatía. Significa entender a la persona que trato, lo que no puede hacerse en condiciones si no participo narrativamente de lo que realmente le ocurre.

De esta manera, la narrativa se constituye en un puente entre médico y paciente (4), lo que tiene que animar al médico a desarrollar lo que vamos a denominar más adelante, la *competencia narrativa*.

**B. Antecedentes**. Platón, en su libro *Leyes*, separa entre:

-La medicina para esclavos, que era una "medicina muda" y de ella se desprendía el saber sobre el malestar físico, es decir, sobre la enfermedad y

-La medicina para ciudadanos libres, donde tenía lugar una conversación amistosa con la persona que consultaba; se trataba de una "medicina comunicativa", que permitía acercarse a la experiencia del enfermo.




En este esquema se muestra con toda claridad la diferencia que existe entre "enfermedad" y "enfermo" y, en este sentido, se plantea una epistemología diferente, pues mientras la primera de ellas se atiene a leyes generales y su

conocimiento es universal (para todos los humanos, en todos los lugares), el segundo se refiere a lo particular sobre lo que no se sostiene el discurso de la generalidad. De este modo, la narrativa médica integra el conocimiento científico (lo general) con una comprensión profunda de las perspectivas personales (lo particular). Así, se acerca la Medicina a los estudios humanísticos.

**C. La historia clínica como narración**. Desde el punto de vista que sostenemos, la historia clínica se convierte en una narración, más que una simple complicación de datos y pruebas a los que suele reducirse. Este punto queda justificado tan pronto como entendemos que el paciente cuando habla no presenta al médico una lista de síntomas (p. ej. inapetencia, náuseas, dolor epigástrico, malestar general, etc.) y tampoco el médico responde poniéndolos uno a continuación del otro, en forma de pila. Antes al contrario, tanto uno como otro elaboran un relato que se pone en relación en la interacción comunicativa.

Tales afirmaciones solo pueden entenderse si pensamos que vivimos dentro de narraciones e, incluso, la misma biografía (lo que uno cuenta sobre su vida) es una narración. Al mismo tiempo, lo que le sucede al paciente es distinto a la manera que tiene de contarlo, dado que los síntomas se interpretan y, en consecuencia, se presentan de distinta forma, según la persona que lo cuente. Así, descubrimos distintos pacientes que cuentan lo que les ocurre como: tragedia, ironía, comedia, suspense, sátira, etc. y se presentan ante el médico como héroes, víctimas, resultado del azar, castigados, etc. La *narrativa médica* permite tomar conciencia de todas estas interpretaciones.

El objetivo no es cuestionar los logros médicos, sino complementarlos mediante la comprensión narrativa del paciente. Si se siguen estos planteamientos, es fácil darse cuenta de que las historias clínicas son muy complicadas y tienen elementos manifiestos, pero también numerosas intrigas (elementos ocultos). De esta manera, el paciente se nos ofrece no solo como organismo enfermo, sino como texto a interpretar y un texto se escucha y se reconstruye (“efecto inter-subjetividad”): atiendo a lo que dice mi paciente y, al mismo tiempo, lo reconstruyo sobre lo que sé y en relación a mi personalidad y mis valores. Se trata de una interpretación sobre la interpretación del enfermo, lo que indica que el texto se escuchar y se reconstruye.

El mismo Freud reparó en este asunto, cuando dijo: “yo no tengo la culpa de que mis historiales clínicos parezcan novelas”.

**D. La *competencia narrativa***. Se trata de la capacidad del médico para recibir las historias de los pacientes y saber qué hacer con ellas. Dado que una cosa son los hechos clínicos y otra la elaboración mental de los mismos, cada vez que se recibe una historia, se construye un texto sobre la misma que no solo incluye los datos clínicos, sino de qué manera el paciente interviene en los mismos. Solo aquellos médicos que tengan en cuenta estos extremos, podrán

reconocer los deseos y motivaciones de sus pacientes. La Competencia Narrativa implica:

1) Un procedimiento particularizador, que busca conocer la singularidad del paciente. Recordemos que Claude Bernard había dicho que: “no existen enfermedades, sino enfermos”.

2) La capacidad para entender aquello que los pacientes dice. Estos no dan el diagnóstico, ni tampoco aportan las claves de su patología; la mayoría de sus expresiones suelen ser ambiguas (p. ej. “no me siento bien”, “me duele todo”). De ahí que haya que privilegiar el relato, que ofrece numerosos elementos para quién sepa escuchar (forma, tiempo, orden, silencios, titubeos, intrigas, etc.).

3) A nivel práctico se trata de crear un clima de confianza, un espacio común donde juntos se construye una narración distinta de la que el enfermo traía y de la que el médico pensó que iba a escuchar. Tiene que ver con el sentido construido del que ya hablaron los teóricos de la Escuela de Palo Alto.

4) Se trata de una creación activa donde el médico es determinante, es coautor del texto. Veamos un ejemplo muy demostrativo de lo que es una construcción común:

> *Un paciente bronquítico crónico acude con su mujer a la consulta diciendo no poder controlar el consumo de tabaco. Mantiene con el médico el siguiente diálogo (P: paciente, M: médico, E: esposa del paciente):*
> *P: Estoy desesperado, cada vez peor. No puedo casi respirar. Creo que este es mi fin.*
> *M: ¿Qué se puede hacer?*
> *E: El no me deja intervenir en nada y le he dicho que me gustaría ayudarle.*
> *M: ¿Por qué no dejas que ella te ayude?*
> *P: Es una persona se mete en todo y al final me siento como un niño.*
> *M: Estamos hablando de algo muy grave, has dicho que estás cada vez peor.*
> *P: ¿Cree que debería consentir que ella controlara el tabaco, aunque me sienta un verdadero inútil?*
> *M: Dadas las circunstancias, sí. Parece la única forma de salir de donde estás.*
> *P: Si usted lo dice, lo haré.*
> *M: No porque yo lo diga, sino porque estés convencido.*
> *P: De acuerdo.*
> *M: ¿De acuerdo en qué?*
> *P: En que ella me controlará el tabaco. Reconozco que soy incapaz.*
> *E: Se lo ha tenido que decir usted para que haga caso.*
> *P: Bueno, bueno. Creo que ahora me he dado cuenta de lo mal que me encuentro y de que no puedo continuar así.*

5) Ya se dijo antes que el mismo hecho puede contarse como: comedia, suspense, sátira, ironía, tragedia, etc., pues bien es posible ayudar a la persona que consulta a realizar un cambio de significación, procurando negociar y renegociar los significados (5). Estos últimos son la parte modificable de las historias, no los hechos en sí pero, como antes se dijo, estos se interpretan. Para entenderlo bien, nada mejor que un ejemplo:

> *Se trata de una estudiante de 20 años, acude a la consulta llorando, ha perdido peso y se encuentra muy mal de ánimo. Habla entrecortadamente, divagando y sin ir al grano respecto a lo que realmente le preocupa. Tras varias sesiones, decide contar lo ocurrido con un sentimiento de vergüenza extremo. Ella es hija única y veranea en la playa con sus padres. Cuando termina el mes de agosto, estos deciden volver a Sevilla y ella pide quedarse unos días más para poder repasar las asignaturas que le quedaron. Cuando se queda sola, decide masturbarse con la figura de una santa local lo cual, tras el hecho, le provoca un grandísimo sentimiento de culpa. Al contarlo lo vive como un verdadero drama (tragedia). Tiempo después, logra calmarse y descubre que no era más que un simple desahogo personal (tranquilización), tras hallarse todo el verano "sometida a sus padres", como ella misma afirma (víctima). Pasadas unas cuantas sesiones, describe el mismo hecho de forma mucho más relajada y logra bromear con lo sucedido (comedia). Finalmente, pasa página respecto a lo sucedido (indiferencia).*

Véase que el hecho es siempre el mismo, es inmutable, pero puede cambiar el significado atribuido al mismo, lo que conduce a un cambio en la subjetivación del mismo. Por consiguiente, contar una historia y escucharla la modifica por completo.

**E. Desarrollo de la *competencia narrativa*.** Para lograr este objetivo, hay que realizar tres movimientos:

1) Atención. Significa estar receptivo y captar cuanto el paciente dice. Trátase de una labor que parece simple, pero que no lo es porque implica dejar de lado los propios contenidos mentales (preocupaciones, tareas, encargos, etc.) para atender a lo que el consultante expone. Para que la atención sea máxima hay que dejarle contar su historia hasta el final.

Si esto se realiza correctamente, el médico se ofrece como instrumento de curación, en la medida en que el paciente puede modificar los significados (errados, morbosos, etc.) asociados a los hechos por él vividos. Gabriel Marcel decía que: "escuchar es una forma de dar".

2) Representación. Significa convertir en lenguaje lo captado mediante la escucha. Se comprende lo que se experimenta cuando queda representado y, al

hacerlo, se realiza un acto de composición, que en sí mismo es creativo. De la misma forma, al escribir sobre lo observado, se descubren detalles en los que no se había reparado y también se produce más atención, con lo que la representación será más precisa.

3) Afiliación. Las narraciones nos unen unos a otros, lo cual puede aplicarse punto por punto a la Medicina. Hablamos de la creación de un vínculo entre el médico y el paciente, pero no solo entre estos dos personajes, sino que la misma narrativa permite forman uniones del médico con sus colegas, con la institución a la que pertenece, con los jefes, etc. Se añade que compartir narraciones ayuda a dar sentido a la experiencia del sufrimiento.

El vínculo que se forma es una creación facilitada por el lenguaje. Si no existe afiliación, las anteriores actividades resultan solipsistas y vacías.

**ATENCIÓN** ⟷ **REPRESENTACIÓN** ⟷ **AFILIACIÓN**
(escucha) (lenguaje) (vínculo)

Existen tres grandes formas de mejorar la competencia narrativa:

1) Escribir. El médico debería acostumbrarse a escribir pero ¿sobre qué? Resulta positivo anotar la historia desde la perspectiva del paciente para conocer cómo se siente y también la opinión que al médico le merece esa construcción y cómo experimenta el contacto con esa persona o qué le despierta. Es posible plantearse, además, las dificultades que tenemos en nuestra práctica y el grado de satisfacción o insatisfacción que tenemos en relación a la misma; todo ello sirve para elaborar las dificultades que se presentan y no llevárselas a cuestas, una vez que la jornada laboral se ha terminado.

2) Leer. Implica un acto de humildad, ya que las ideas que tengo no son las mejores ni las únicas y conocer la experiencia de otros facultativos resulta fundamental para compararla con la nuestra. El saber médico es asintótico, pues se constituye como un *no-todo,* ya que no es posible conocer todo lo que se está escrito sobre un asunto determinado; incluso, muchos territorios de la Medicina aún permanecen ignotos. Recordemos que Descartes decía: “daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro”, frase totalmente aplicable a la Medicina, donde es más el terreno de lo desconocido que de lo conocido.

Al mismo tiempo, la lectura de obras literarias posibilita ahondar en los sentimientos y emociones humanas, lo que va a permitir al médico reconocer mejor la experiencia subjetiva del enfermo en relación a su proceso patológico.

3) Reflexionar. No hay que creerse todo lo que se lee, hay que intentar ser críticos. A título de ejemplo, en Psicología existen muchísimos libros que están publicados y no tienen ningún fundamento, se trata de los llamados de

"autoayuda"; su misión, muchas veces (salvo un puñado de excepciones), no es orientar a las personas sino equivocarlas. La reflexión no solo lleva a ser críticos, sino que ayuda a encontrar ideas nuevas que puedan servirnos para la práctica.

**ESCRIBIR** ⟷ **LEER** ⟷ **REFLEXIONAR**
Saber médico asintótico (no-todo)
Nuevas ideas

**E. Resultados de la *narrativa médica*.** El empleo de la moderna narrativa médica en el contexto clínico produce como efectos:

a) Estimula la imaginación. En una buena medida, la Medicina procura cuadricular las mentes de quiénes se forman (síntomas precisos, diagnósticos certeros, pruebas indicadas, protocolos de actuación, etc.), pero la narrativa limita esa concreción y abre senderos nuevos (rutas mentales novedosas).

b) Incrementa el conocimiento de lo humano. Dado que tratamos con personas, que sienten y padecen, la narrativa limita la cientificidad a ultranza, que intenta generalizar los datos y deja de escuchar a la persona (como particular).

c) Incluye la incertidumbre en la práctica. Cualquier intento de hacer del ejercicio médico una práctica matemática se va al traste; aquí "dos y dos" no son "cuatro". Por consiguiente, limita la rigidez y la seguridad excesiva.

d) Enseña a pensar y estimula la crítica. Ya se dijo que el médico tiene que ser reflexivo y con esta acción se limita el dogmatismo y la repetición, cosa frecuente en determinas escuelas médicas. Ningún saber es imperecedero.

e) Enseña a respetar(se). Esto se debe a que admite distintos puntos de vista como certeros dado que, como antes se dijo, la "verdad absoluta" no existe. Con ello se limita la rivalidad y la lucha por saber quién tiene la razón; puntos de vista diferentes sobre un mismo paciente pueden ser ciertos.

f) Previene el agotamiento. Tiene que ver con que la actividad diaria del médico provoca frecuentes tensiones emocionales, que hay que gestionar adecuadamente. Si no se hace así, si no se elaboran las reacciones emocionales, el profesional de la Medicina acaba agotado. Comprender lo que está sucediendo disminuye el sufrimiento. Volveremos a este mismo asunto en el próximo capítulo.

g) Crea un puente entre médico y paciente, Al atender el primero al segundo y procurar aceptar su punto de vista, hace que se abra más y relate nuevos contenidos útiles para completar la historia clínica. De esta manera, se limita el secretismo y la desconfianza mutua; el paciente siente que el médico está de su parte y que no va a experimentar con él, por consiguiente, pone coto a la paranoidización del paciente.

### 5.3. Habilidades procesuales.

En este apartado se trata de esclarecer cómo debe actuar el médico cuando se encuentra con el paciente y con ello entramos directamente en el aspecto técnico de la relación. Se intenta responder a la pregunta: ¿de qué herramientas dispone para actuar con el enfermo de manera efectiva?

**5.3.1. El vaciamiento de la información.** La finalidad primera del contacto con el paciente va a ser que hable y cuente aquello que le preocupa, a ser posible minimizando las reservas. Esto se debe a que, en la consulta, nos enfrentamos a numerosas realidades, no solo debidas a la enfermedad sino a cuestiones personales, que deben ser expresadas. Incluso, muchas de estas preocupaciones, tienen que ver con la propia enfermedad aunque el paciente no relacione ambas cosas (p. ej. no asocia el consumo de porros con el problema de atención y de memoria que tiene y consiguiente pérdida de capacidades para el estudio).

Este hecho justifica por sí solo la necesidad de aprender estrategias para intervenir en la relación (p. ej. hacer preguntas correctas, manejar los silencios, dar la respuesta adecuada, etc.). Existen métodos pautados para llegar al diagnóstico, pero hace falta un entrenamiento del médico dirigido a introducir el trato con las personas.

**5.3.2. La escucha activa.** Para lograr el vaciamiento de la información, resulta imprescindible lo que actualmente se denomina *escucha activa*. Trátase de una forma de comunicación que demuestra al hablante que el oyente ha entendido; para conocer bien como se pone de manifiesto en la práctica, hay que diferenciar entre los siguientes términos (que no son sinónimos aunque lo parezcan):

-Oír. Implica percibir ondas sonoras que están en el aire, pero no significa entender lo oído. Puedo oír a un ruso como habla, incluso parecerme musical su idioma, pero no me he enterado de ni una sola palabra.

-Escuchar. Significa entender o dar sentido a lo expuesto. Aquí se supone que entiendo los sonidos vocálicos que me llegan (existe un mismo código), pero no basta con eso pues se precisa que esté atento a lo que se expresa. Lacan decía que para poder escuchar, el *yo* tiene que quedarse fuera de la consulta; efectivamente, si no dejo de lado mis problemas, ideas, aficiones, planes, etc. no puedo atender a quién tengo delante. No se puede estar atento a dos cosas al mismo tiempo.

> *Este es el caso de una chica de 17 años, quién en la consulta está tecleando en su móvil y al mismo tiempo hablando de su problema. Al indicarle su postura, dice muy convencida: no se preocupe usted, yo le*

*escucho perfectamente mientras contesto a los mensajes. Evidentemente, no se enteró ni una palabra de lo que se le dijo, pero ella creía que sí.*

-Escucha activa. Esta última implica que el paciente tiene que sentir que se le ha entendido; para lograrlo hay que transmitirle algo que así lo demuestre. Luego estudiaremos las *paráfrasis* como un modo extraordinario para lograr este cometido; por ahora, basta con decir que una respuesta como esta: "creo que quiere indicar que su vida no es la de antes después de su jubilación", provoca un efecto impresionante en el paciente, pues va a favorecer su expresión verbal y su comunicación se hace más fluida.

| **DISCURSO** → | **OIR** → | **ESCUCHAR** → | **ESCUCHA ACTIVA** |
|---|---|---|---|
| | Percibir ondas sonoras | Dar sentido a lo oído Atención | El paciente siente que se le ha entendido |

**5.3.3. Técnicas y estrategias.** Pueden separarse en dos grupos independientes:

**A. Para que el paciente se exprese.** Ante el médico el paciente se siente como un extraño y está angustiado, por eso hay que ayudarle en la expresión. Van a utilizarse las siguientes:

a) Facilitadores. Promueven la continuidad del discurso, de tal manera que, por lo menos al principio, este suele ser entrecortado, con numerosos puntos suspensivos (silencios).

----------…… ----------…….----------

Consisten en expresiones del tipo: "ajá", "siga por favor", "vale", "entiendo", "claro", "desde luego", etc. y se supone que, al utilizarlas, el paciente seguirá hablando.

b) Validación. En este caso las frases utilizadas dan noticia de que se acepta lo que el paciente dice, aunque se esté en desacuerdo. Puede tratarse de: "muy bien dicho", "seguro que tomó la decisión correcta", "hizo bien", etc.

c) Paráfrasis. En general los profesionales de la salud tendemos a preguntar demasiado y a mendo se trata casi de "interrogatorios policiales" (p. ej. ¿come bien? ¿cómo orina? ¿duerme bien? ¿se encuentra bien de ánimo? ¿se pone nervioso habitualmente?, etc.). Esta forma de preguntar se encuentra proscrita hoy en día y se requieren formas de obtener información sin llegar a atosigarlo o acorralarlo. Es justamente lo que le pasó a Freud con una paciente (Emmy), la cual le solicitó que dejara de preguntarle constantemente de donde venía esto o aquello; el genial médico vienés, cesó de hacerlo y con ello inventó un nuevo procedimiento de cura, que la paciente llamó *talking cure* ("cura por la palabra").

La paráfrasis es una alternativa muy poderosa a la pregunta y consiste en repetir lo que el paciente ha dicho pero utilizando otras palabras. Veamos el siguiente texto (P: paciente, M: médico):

*P: Vengo a su consulta porque estos días he tenido un gran dolor en el pecho y, a tanto llegó, que tuve que ir directo al hospital (se queda mirando en silencio, esperando una pregunta del médico).*
*M: Acude buscando ayuda por haber sentido un gran malestar, que le hizo perder la calma y le obligó a acudir a urgencias.*
*P: Sí doctor, es correcto. Pasé un miedo horroroso porque pensé que me moría (silencio).*
*M: O sea, que llegó a creer que ese era su último día.*
*P: Si. Se puede imaginar como estaba. Curiosamente, no puedo identificar nada que me lo haya provocado. No pasó nada, no hubo una discusión en casa, ese dia de trabajo fue tranquilo. Incluso, al salir, me tomé unas tapitas con los compañeros (silencio).*
*M: Quiere decir que apareció sin justificación alguna.*
*P: Ciertamente. Eso es lo que ocurrió. Nunca me he visto así y tampoco mi mujer. Ella se asustó muchísimo por cómo me encontraba (silencio).*
*M: Total que ha sido algo que le ha sorprendido no solo a usted, sino también a su mujer.*

Las paráfrasis no tienen por qué hacerse tan frecuentemente, de hecho en esta entrevista se hizo porque el paciente se comunicaba con largas pausas. A veces, incluso una paráfrasis se puede hacer después de una larga emisión de palabras (recapitulación).

Puede también utilizarse la paráfrasis para hacer notar algo importante al paciente; para ello, se repite textualmente lo que ha dicho, pero empleando una entonación diferente, como pueden ser estos dos diálogos:

P: Sigo fundando un paquete al día.
M: ¿¡Cómo!? ¿¡Todavía sigue fundando un paquete al día!?

P: Yo sigo haciendo lo de siempre: tengo relaciones sexuales y no utilizo ninguna protección.
M: ¿¡No me lo puedo creer!? ¿¡Aún continua teniendo relaciones sexuales sin protección!?

d) Definir un estado afectivo. En este caso, el paciente es muy parco en palabras, sobre todo aquellas que pertenecen al territorio de las emociones y sentimientos. Entonces, se le hace una pregunta sobre lo que siente y, a continuación, se nombra el afecto que el paciente es incapaz de definir.

M: ¿Cómo se sintió cuando su pareja le dijo que no?
P: Pues mal.
M: Yo creo que se sintió muy contrariada.
P: Así es.

Esta acción permite al paciente tomar conciencia de sus propias emociones.

e) Ampliación. Supone pedir una nueva información, mediante preguntas (a ser posible abiertas) o afirmaciones ("dígame algo más sobre eso", "¿cómo reaccionó su madre cuando le dijo que estaba embarazada?", "no entiendo muy bien, ¿me lo puede explicar?, etc.).

f) Delimitación. Es la intervención contraria a la anterior, pues posibilita que el paciente se centre en algo, sobre todo cuando generaliza ("póngame un ejemplo", "eso que cuenta ¿cómo ocurrió realmente?) o se va por las ramas y se le intenta conducir al tema ("me estaba diciendo que usted bebe alcohol", "ha tocado varios temas al mismo tiempo ¿de cuál quiere hablar?).

g) Silencios. El paciente está hablando y de pronto se queda callado; se trata de una cuestión a la que, frecuentemente, hay que enfrentarse en las consultas y hay que saber manejarla. Para ello hay que distinguir dos tipos:

-El *funcional*, que es cuando está diciendo algo y se queda callado pudiendo tratarse de que está pensando. Tal cosa puede suceder tras una intervención del médico (p. ej. "dice que su novia es la responsable de todo, pero puede que usted tenga algo que ver en ello"). En este caso, se le deja el tiempo suficiente para reflexione y dé la respuesta que estime más conveniente.

-El de *vacío de información*. Aquí el paciente no tiene nada que decir, por consiguiente hay que hacer algo para que el discurso continúe (facilitadores, paráfrasis, pregunta abierta, etc.).

**B. Para que el paciente tome conciencia.** Con las intervenciones que se muestran a continuación, se trata de que el sujeto se aperciba de algo que le está pasando o de la situación por la que atraviesa; son las siguientes:

a) Información. Combate la ignorancia, actuando el médico como educador. Puede informar al paciente de: sus derechos, medidas higiénicas, en qué consiste la psicoterapia desmintiendo que acudir a realizarla significa "estar enfermo mentalmente", etc. Las informaciones privilegiadas son aquellas que facilitan la ejecución de conductas de salud y evitan los comportamientos de riesgo; ambas actúan de forma preventiva.

b) Intervenciones directivas. Son aquellas que dirigen la conducta del paciente y suponen el ejercicio de la *función promotora* de la comunicación. Deberían utilizarse solo cuando el paciente se encuentra frente a un peligro o puede meterse en un problema importante (para la salud o para su vida), como es el siguiente caso:

*Paciente de 56 años de edad, padece obesidad mórbida. Le encanta asistir a matanzas, en las que come de una manera exagerada, lo que justifica diciendo que: "allí todos comen muchísimo". Dado que las últimas analíticas presentan unas cifras "disparadas", se le dice (directivamente): "como no pare de asistir a matanzas, el próximo que va a morir es usted".*

c) Sugerencia. Se trata de un grado menor que la anterior y, por lo tanto, más favorable, dado que los médicos no podemos abusar de las intervenciones directivas. Las sugerencias suelen ser bien toleradas por el paciente. Veamos algunos ejemplos:

*Un chico que recientemente ha terminado el grado universitario y tiene bastantes posibilidades de trabajar en la profesión que él ha elegido. Sl mismo tiempo se siente atosigado por su novia para casarse cuanto antes. Detrás de esa pretensión se encuentra el deseo de ella de salir por fin de su casa (no ha terminado aún los estudios) y de la idea de sus padres de que ya es hora de que se vaya. Él se encuentra en conflicto ya que, por un lado, quiere y, por otro, no; en este estado acude a consultar bastante angustiado. La sugerencia es la siguiente: a lo mejor te conviene tomarte un tiempo para reflexionar y aclararte, antes de tomar una decisión definitiva y no continuar con la prisa que te están metiendo. El paciente agradece estas palabras y se tranquiliza, dándose un tiempo para poder poner en orden sus ideas y saber exactamente qué desea.*

*A un paciente de 46 años, le propone un antiguo compañero de colegio un negocio "seguro" para el que tendría que aportar unos 20.000 euros. Según su excompañero, la decisión tendría que ser muy rápida porque corre prisa el asunto, de lo contrario contaría con otra persona. El paciente se siente un poco agobiado, de ahí que la sugerencia sea esta: "yo que tú, antes de arriesgar esa cantidad, me informaría de quién es este hombre hoy en día, ya que lo que recuerdas de él es bastante remoto. Tendrías que saber si cumple, si es responsable, los negocios en los que ha estado metido antes,…". Haciendo caso a mi sugerencia, se empapa bien de donde se va a meter y descubre bastantes aspectos que no están demasiado claros.*

d) Señalamiento. Aquí lo que se hace es indicar puntos de interés que ayuden al paciente a percatarse de algo (es el "date cuenta"). Tiene bastante utilidad en los siguientes casos:

-Indicar un estado afectivo propio, que el paciente no capta. Pueden ayudarle frases como: "le veo preocupado" o "parece triste".

-Temas que el paciente deja de lado. A menudo este no quiere tratar con su médico temas que resultan ser centrales para su patología y, caso de abordarlos, lo hace de manera puntual. En este sentido, son señalamientos los

siguientes: “se ha fijado que, cada vez que hablamos de su consumo, se le queda la mente en blanco y no puede recordar” o “cuando le digo algo de los pasteles, me cambia de tema”.

Después de un señalamiento se deja un tiempo para que reflexione o exprese lo que siente (“silencio funcional”). Puede ocurrir que el médico no sabe señalar, como es el caso siguiente:

*P: Me duele el pecho desde hace tiempo. A mi padre le pasó esto mismo y murió.*
*M: ¿Las piernas también le duelen?*

En este ejemplo el médico ha perdido la oportunidad de acercarse al miedo del paciente; sencillamente podría haberle dicho: “parece que tiene miedo a que le ocurra lo mismo que a su padre”. Si hubiera actuado así, el paciente se hubiera expresado y hubiera sido un momento muy bueno para tratar el miedo.

e) Clarificación. Indaga un material oculto del que el paciente no tiene noticias o no quiere abordarlo. Pueden utilizarse para:

-Esclarecer un sentimiento: “debe estar pasándolo realmente mal después de la muerte de su esposa”. Se diferencia del simple *señalamiento* en que este último se dirige tan solo al estado afectivo (p. ej. “lo veo muy intranquilo”), mientras que la clarificación va más allá, al conectar lo que siente con la situación. Sorprende que, muchas veces, teniendo las claves delante de sus narices, no las ven:

*Una mujer de 30 años, muy sociable y que no puede pasar ni un día sin contactos sociales (personalidad histriónica), acude a la consulta hallándose bastante triste y sin ganas de nada. Esta tristeza tiene relación comprensible con el confinamiento debido al COVID-19 pero, al preguntarle sobre la misma, dice no saber a qué se debe y que le parece a ella que es algo “genético”. Se pone mucho mejor, tan pronto como asocia ambas cosas.*

Otras veces, el paciente tiene miedo, pero no lo puede ver. Así lo entendió una persona cuando le dijimos: “lo que ha expuesto es que está bastante preocupado por haber perdido 9 kilos en 6 meses ¿no es así?”.

-Aclarar una situación confusa, como es el caso siguiente:

*Un paciente joven acude a la consulta, por “encontrarse completamente perdido”. Tras un estudio de la situación se descubre la reciente muerte del abuelo, mientras el paciente niega que este hecho singular le haya afectado. Sin embargo, el abuelo era la persona que solventaba todos los problemas, de manera que, cada vez que se presentaba algo extraordinario, los reunía a todos en su casa y distribuía las tareas para*

*solucionarlo. Ante este descubrimiento, una clarificación que le sirvió bastante fue la siguiente: "lo que está ocurriendo en tu familia es que, tras la muerte del abuelo, todos están desbocados. Nadie sabe lo que tiene que hacer exactamente, incluido tú".*

f) Interpretación. Hay que tener muy claro que este tipo de intervenciones se reservan para personas expertas, debido al peligro que conlleva pues puede incluso desencadenar un brote psicótico, en una persona que tenga esta predisposición). Sin embargo, llama la atención lo alegremente que se utiliza; veamos un ejemplo:

*Una paciente de 57 años, es una persona silenciosa, tímida, rara y se ha interesado por temas extraños (ovnis, apariciones de fantasmas, etc.), teniendo sus propias ideas (fuera de lo común) sobre estos fenómenos. Un día que acudió a un profesional de salud que ya conocía para consultar sus problemas y este le dijo: "yo ya sé lo que te pasa y es que tú nunca has querido a nadie, ni a tu familia de origen, ni tampoco a tu marido y a tus hijos menos". A la paciente se le mudó la cara y al poco tuvo que ingresar en Psiquiatría, porque estaba delirando.*

En una interpretación se busca el sentido profundo de los acciones, síntomas o rasgos de la persona. Mientras que la clarificación alude a los procesos conscientes o, si acaso, preconscientes de la persona, aquí se trata de buscar las motivaciones inconscientes. Obsérvense las siguientes interpretaciones:

*"Parece que la parálisis respecto a los estudios tiene que ver con que no quieres enfrentarte a las responsabilidades de ser médico y es más cómodo para ti quedarte como estudiante, suspendiendo, que terminar y tomar las riendas de tu vida".*

*"No apruebas ninguna asignatura porque tener el título significa volver al pueblo con tu madre, de la que, al mismo tiempo, dependes, y de la que quieres alejarte".*

Hay que fijarse en que para hacer una interpretación: 1) hay que conocer muy bien a la persona que se está tratando, 2) solo debe realizarse en un contexto controlado (en un proceso psicoterapéutico reglado), contenedor, y nunca de manera "salvaje", fuera de este medio, 3) tiene que ser estrictamente necesaria, 4) es específica de cada persona y solamente tiene utilidad para ella y 5) solo puede realizarla, como antes se dijo, personas expertas.

**BIBLIOGRAFÍA.**

1. Charon R. Narrative Medicine. Honoring the Stories of Illness. Oxford University Press, 2006.
2. Schön DA. La formación de profesionales reflexivos. Barcelona: Paidós, 2002.
3. Carrió S. Aproximaciones a la medicina narrativa. Rev Hosp Ital B Aires; 26(1): 2006.
4. Greenhallgh T, Hurwitz B. Narrative based medicine. London: BMJ Books, 1998.
5. Bruner J. Actos de significado. Madrid: Alianza, 1991.

## Capítulo 6º. Desarrollo y aprendizaje de habilidades de comunicación (II): c) Cognitivo-emocionales: actitud ante las emociones, empatía clínica y asertividad. d) De objeto: diagnóstico, pronóstico y tratamiento.

### 6.1. Actitud del médico ante las emociones.

Independientemente del motivo de una consulta, siempre existe un aflujo de emociones, debido a que: 1) la enfermedad no está separada de la persona y 2) se convierte en una situación adversa que desencadena tensiones, relacionadas con las circunstancias puntuales que pueden darse durante el proceso (p. ej. frustración de planes, interrupción de proyectos, pruebas dolorosas, hospitalizaciones, efectos secundarios de los tratamientos, etc.).

De ahí que el médico tenga que ser un experto en gestionar emociones porque:

a) el paciente tiene que descargarlas (*catarsis* liberadora),

b) para hacer la RME más armónica (*rapport*) y

c) lograr acuerdos.

Estas premisas se hacen ciertas con solo pensar que los mensajes cargados emocionalmente no llegan a su destino. Recordemos que una característica de estos movimientos afectivos intensos es que disuelven la racionalidad, en cuyo caso al interlocutor le quedan dos opciones: se desconecta o entra en una lucha “cuerpo a cuerpo” con la persona presa de la emoción.

Se trata de planteamientos que no son nuevos, pues estaban ya plateados en Hipócrates, quién decía que no se trataba solo de describir la enfermedad, sino también al enfermo. La medicina griega se caracterizaba por el especial cuidado que ponía en los elementos psicológicos asociados a la enfermedad.

Ahora es el momento de plantear qué debe hacer el médico con las emociones de sus pacientes, ¿cómo puede manejarlas? Se trata de un asunto relativamente moderno dentro de la Medicina, ya que bajo el modelo biomédico tan solo importaban los síntomas, el diagnóstico y el tratamiento. No significa que estos ya no se tengan en cuenta sino que, como médicos tenemos que hacer algo más. Para manejar las emociones, seguimos varios pasos:

**6.1.1. Captarlas.** Lo primero es darse cuenta de que existen. Cualquier emoción presenta una doble expresión:

a) La no-verbal, que es la más inmediata, puede observarse y no es consciente. Se descubre por: la mímica (llanto, rostro constreñido, boca fruncida, etc.) y por el lenguaje corporal (temblor de manos, contracturas, movimiento de

piernas, dirigir el cuerpo hacia delante, etc.). Tenemos que tener mucho cuidado con darle un significado rápido, ya que:

-La expresión emocional es cultural. Darwin se equivocó cuando afirmó que en todas las culturas las emociones se ponían de manifiesto de la misma forma (1); se ha visto que, por el contrario, cada grupo humano las expresa de modo diferente. De ahí que no podamos adelantarnos en este sentido, un aspecto de gran relevancia cuando atendemos a personas de otras culturas.

-Lo extraverbal es indecible. No vamos a añadir ni una coma a este punto, puesto que lo tratamos en el capítulo 2º.

-Para otorgar el sentido correcto a una emoción hace falta el contenido verbal de la misma, lo que podríamos llamar la *narrativa de la emoción*.

b) La verbalización de una emoción aparece con posterioridad, cuando la persona intenta saber qué le está sucediendo. En el siguiente apartado veremos la denominación que tienen las diferentes emociones.

Percibir las emociones de los pacientes va a depender de:

-la sensibilidad que tenga el médico (empatía),

-la atención que ponga en sus pacientes,

-la aparición de ciertas que le impiden captarlas, dando lugar a especie de "ceguera emocional". Este es el caso de la negación ("esto no está sucediendo"), la justificación ("se encuentra en un sitio que no es su casa, por eso está as´", "tiene discusiones con su pareja, por eso se enfada tanto") o la intelectualización (el médico solo atiende a esquemas teóricos, criterios diagnósticos y protocolos terapéuticos, el resto no le importa).

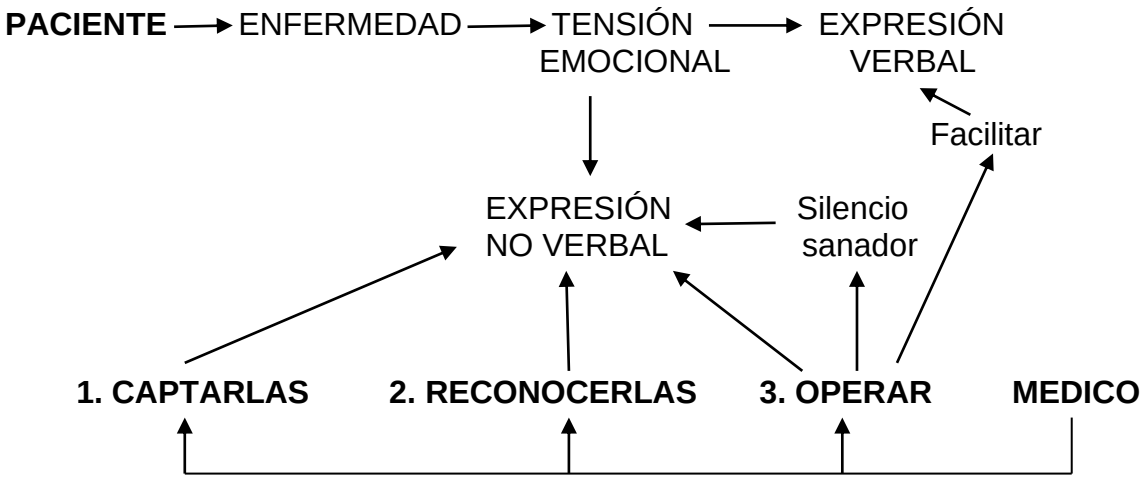
De ahí que sea muy importante en la formación médica:

-El autoconocimiento. Saber cómo es y que rasgos de su personalidad pueden interferir en su profesión y cuáles no. En el capítulo de la *entrevista* abordaremos este asunto.

-La autogestión emocional, que implica desarrollar un aparato mental continente de los movimientos emocionales, implicando la existencia de un lenguaje sobre las estas experiencias intentensas amplio y elaborado.

Ambas características pueden desarrollarse convenientemente realizando psicoterapia, tanto individual como grupal.

**6.1.2. Reconocerlas.** En este segundo paso de lo que se trata es de definir el tipo de emoción del que se trata; para ello, nada mejor que repasar cuáles son las emociones básicas:




a) La alegría. Júbilo y felicidad momentánea que aparece ante una ganancia (p. ej. un premio en un cupón, un encuentro con alguien que hacía tiempo que no se veía).

b) La tristeza. Pena instantánea que surge ante una pérdida (p. ej. robo de la cartera).

c) La ira. Enojo relacionado con una contrariedad (p. ej. no poder sacar una entrada porque se han agotado). Puede poner en marcha el comportamiento agresivo.

d) Asco. Repugnancia hacia algo considerado desagradable (p. ej. bichos) o en relación elementos materiales que salen del cuerpo (p. ej. orina, vómitos, heces, …).

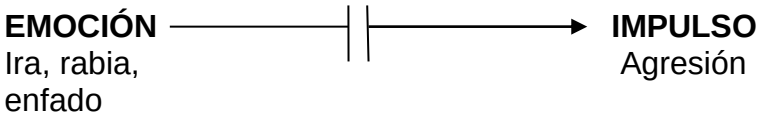
e) Miedo: alerta debida a un peligro (real o imaginario) y la correspondiente necesidad de escape instantánea (p. ej. aparición de unos pasos mientras camino de noche por una calle oscura).

f) Sorpresa: reacción ante algo inesperado (p. ej. una fiesta de cumpleaños de la que no me avisaron). Puede llegar a la perplejidad, cuando surge una incapacidad de organizar aquello que se percibe respecto a la experiencia anterior (p. ej. una paciente se encuentra a su marido con otro hombre en la cama).

g) Preocupación: pérdida del sosiego o tranquilidad natural, debida a que algo que no acaba de resolverse y ronda en la cabeza (p. ej. no sé si conseguiré salir de un problema familiar que tengo).

Hay que ser muy prudente a la hora de identificar las emociones porque: 1º) pueden simularse, para conmover u obtener ventajas (p. ej. que no me abandone mi pareja, que mi hijo llegue temprano a casa) y 2º) el médico tiene que conocerse bien, para no proyectarse en el paciente.

**6.1.3. Operar**. Antes que nada hay que decir que no hay que tenerle miedo a las emociones y, si se tiene, es porque quién las recibe cree que a continuación vendrá un impulso. Esto sucede sobre todo con la ira, la cólera o enfado, que inducen al interlocutor a creer que, tras cualquiera de ellas, tendrá lugar una agresión. Tal efecto es impensable en personas normales y bien adaptadas al medio, ocurriendo solo en condiciones extremas o en trastornos de la personalidad (individuos que no controlan sus impulsos); luego, en condiciones normales se espera un control, mientras la emoción fluye libremente hasta disiparse.




Las actuaciones del médico deberán ser las siguientes:

a) Actitud acogedora. Significa guardar silencio cuando el paciente las expresa, pensemos que están desahogando las tensiones emocionales (*catarsis*). En este momento conviene:

-Adoptar un afecto neutro (evitar la simpatía/antipatía, el agrado/desagrado, atracción/repulsión, etc.).

-Abstenerse de evaluar, los famosos "juicios morales" ("estás llorando como una mujer", "eres una persona débil", "si lloras actúas como una niña", etc.). Recordemos que Nietzsche decía que: "el juicio moral es el arma de los débiles".

-No calmar inmediatamente. Pensar que una emoción es temporal y tiene una corta duración, lo que lleva a dejar que el paciente la explaye hasta el final.

-No banalizar ("no es para tanto", "pero, si es una tontería, usted tiene posibilidades con otros hombres"). Si al paciente le afecta algo es porque se trata de algo importante para él, aunque el médico lo vea injustificado ("efecto subjetividad").

-Se aconseja sacar a la familia, pareja o acompañante, dado que se produce el "contagio emocional", en cuyo caso la emoción puede prolongarse.

-Si se trata de ira, conviene no enfrentarse al paciente. Continuar con la actitud neutral.

b) Facilitar la expresión verbal. Para los pacientes suele ser más fácil narrar el hecho o la situación perturbadora, y lo suelen hacer con mucha carga, pero no nombran la emoción explícitamente. Se hace necesario que la defina, que le ponga nombre (al idioma de las emociones lo llamamos "emocionalés", lo mismo que hay "francés" o "inglés"). Existen personas incapaces de realizar esta operación, en cuyo caso hablamos de *alexitimia*; se trata de un término acuñado

por Peter Sifneos, profesor de Psiquiatría de la Universidad de Harvard, en los años 70. Este afamado autor habla de sujetos incapaces de reconocer las emociones por falta de los términos que las definen; en consecuencia, presentan una vida interior empobrecida y les resulta imposible realizar introspecciones.

Otros autores han abordado el mismo asunto, denominándolo “pobreza de simbolización” (Ruesch) o “analfabetos emocionales” (Nemiah).

Sin llegar a padecer *alexitimia*, en condiciones normales las emociones pueden ser difíciles de definir con exactitud porque:

-Se utilizan términos inespecíficos para aludirlas (p. ej. “me siento mal”, “no estoy bien”, “estoy nervioso”, “me encuentro estresado”, “voy tirando”, etc.). Cualquiera de estas palabras no precisa la emoción de la que se trata.

-Ciertas emociones pueden ponerse de manifiesto (y expresarse) de distintas formas; así, puede hablarse de “tristeza” como: aburrimiento, falta de ganas, estar acobardado, no tener energía, etc. Como cabe entender, ni el mismo paciente la identifica correctamente.

-Pueden producirse varias emociones al mismo tiempo (simultánea o sucesivamente); se puede pasar de la risa al llanto, de la alegría a la tristeza, del pesar a la euforia insulsa, etc.

Siempre que pueda, el médico tiene que ayudar a ponerles nombre; para ello contamos con la *petición de paráfrasis afectivas*. Se actúa preguntando y después nombrando a la emoción (significante emocional).

*P: Fui sin muchas ganas al encuentro familiar.*
*M: ¿Cómo se sintió? (petición de paráfrasis afectiva).*
*P: Mal (respuesta inespecífica).*
*M: Creo que se aburrió un poco (paráfrasis afectiva).*

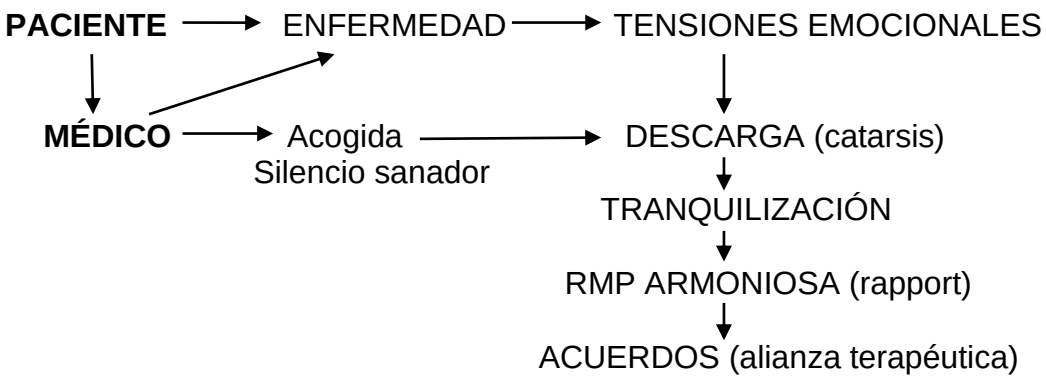
En este caso, el significante emocional es “aburrimiento”. Como se dijo antes, para realizar esta labor adecuadamente, el médico tiene que contar con un vocabulario amplio y preciso en relación a la afectividad; si es así, podrá denominar a una gran variedad de experiencias afectivas. En el siguiente grafo presentamos la cascada de eventos que se suceden cuando el médico maneja en condiciones las emociones del paciente.

## 6.2. La empatía clínica.

**6.2.1. Concepto de empatía.** El término *empatía* se lo debemos a Edward B. Titchener, discípulo de Wundt, quién lo presentó en una conferencia en el año 1909. A partir de entonces se entiende como la capacidad para sumergirse en el mundo subjetivo del otro y ser capaz de captar su experiencia emocional y cognitiva. Implica estas dos premisas:

a) identificar lo que necesita y lo que hace daño y

b) anticiparse a situaciones y deseos.




Evidentemente, no todo el mundo tiene estas capacidades, existiendo personas carentes de empatía y algunas, que conociendo la de los demás, son capaces de utilizarla para hacer daño: manipular, aprovecharse, torturar, mentir, chantajear, etc.; ciertos trastornos de la personalidad hay que incluirlos en este apartado. Luego veremos donde se encuentra el equilibrio de empatía.

**6.2.2. Niveles de desarrollo de la empatía**. Existen tres:

a) El más básico es el *contagio emocional*. Varios individuos se ven afectados por una misma emoción, cosa que sucede en los espectáculos (concierto, el teatro, el cine, etc.), en el llanto de los niños (llora uno, lloran todos), la risa, el bostezo, etc.

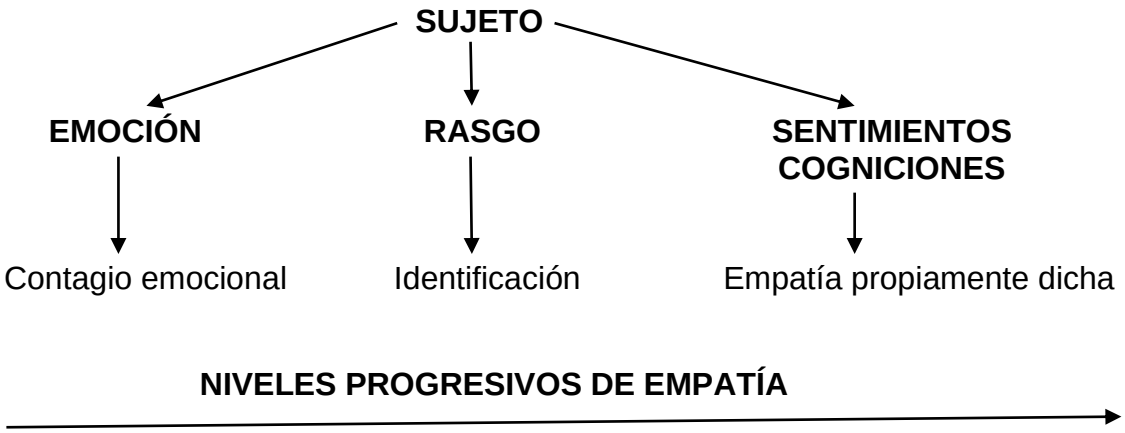
b) Un segundo nivel es la *identificación*. Se imitan expresiones, posturas, tono de voz, acento, palabras, etc. de otro sujeto e, incluso, puede utilizarse su ropa, cambiarse el color de pelo, etc. Es automática, inconsciente y escapa al control; aparece con más frecuencia e intensidad cuando la persona es admirada por alguno de sus rasgos.

> *Estando en el curso en Madrid, impartido por un profesor que venía de Argentina, pronto se descubrió que este hombre tenía una tos in crescendo. No podía evitarla e iba aumentando en intensidad progresivamente. Todos los presentes estábamos encantados con su forma de enseñar y por el (extenso) contenido de sus explicaciones. A media mañana se decidió hacer un descanso y fuimos al bar. Entonces, fue bastante curioso comprobar cómo en el grupo sonaron algunas toses con la misma forma entre los asistentes. Una identificación con el profesor admirado.*

Esta forma elemental de empatía se ha utilizado muchísimo en la publicidad. Si quieren vender un coche, ponen a un conductor y a su lado una mujer muy bella; el mensaje está claro: si compras el coche vas a tener mujeres como esta.

c) Finalmente, tenemos la *empatía propiamente dicha*. Se trata de sentir de manera similar a quiénes observamos o escuchamos, lo que nos permite comprender los motivos de su malestar o bienestar. Se trata de uno de los mayores logros de la evolución humana, pues sin ella probablemente no hubiéramos sobrevivido como especie. En este sentido, Alfred Adler, discípulo disidente de Freud, habló del *sentimiento de comunidad* que nos ayuda a unirnos unos a otros superando el *afán de poder* individual.

Pero, solo sentimos una versión o dosis de la empatía ajena, de lo contrario no se podría trabajar en ciertas profesiones, como médicos, bomberos, enfermeros, trabajadores sociales, etc. (p. ej. si alguien ha perdido un brazo por un traumatismo no sentimos su dolor, aunque coloquialmente se pueda afirmar que es así).




**6.2.3. Fundamentos de la empatía**. La existencia de la empatía puede entenderse desde dos puntos de vista diferentes:

a) Neurológico. En 1966 el neurobiólogo Giacomo Rizzolatti, afincado en la Universidad de Parma, descubrió por casualidad las *neuronas espejo.* Estudiando las células nerviosas del movimiento en macacos al coger frutas, de pronto el mismo cogió una pieza y contempló como las neuronas del animal se activaban sin realizar movimiento alguno. Concluyó que hacer una acción y verla es lo mismo a nivel cerebral; en consecuencia, estas células nerviosas permiten experimentar al observar situaciones sin realizarlas.

b) Psicológico. El psicoanalista francés Jacques Lacan, en 1936, presenta a la comunidad científica el *estadio del espejo* (2). Consiste en lo siguiente: el niño pequeño experimenta su cuerpo con una gran impotencia, debido a que no puede

dominarlo (su cabeza no se sostiene, intenta levantarse y cae al suelo, no domina sus piernas, etc.). Lo vive como si estuviera separado en segmentos que no puede reunir entre sí (*fantasías de fragmentación corporal*) pero, al acercarse al espejo, encuentra una imagen intacta de sí mismo y eso le fascina y atrapa. Mientras el chimpancé, al hacer esto mismo, rápidamente se desinteresa por su imagen, el niño se queda pegado al complejo virtual; entonces, al verse reflejado de modo completo, organiza las distintas partes que siente separadas en una imagen única y completa. Este momento tan importante tiene lugar entre los 6 y los 18 meses y representa, para Lacan, una anticipación de la unidad que conseguirá más tarde y la esperanza del fin de un malestar físico que le inunda.

A partir de ahí, las relaciones con los demás seres humanos tendrá esta nota especular: buscamos que nos devuelvan la imagen y, para ello, intentamos agradar, gustar, quedar bien, etc. La empatía se asocia directamente a estos fenómenos especulares, ya que tiene lugar un fenómeno que se llama *transitivismo*, que consiste en la ausencia de separación respecto a los fenómenos psicológicos que tienen lugar entre niños, así si alguno de ellos se golpea un dedo el amiguito llora; puede perdurar en los adultos (“el ladrón cree que todos son de su condición”).

**6.2.4. El equilibrio de empatía**. Antes se sugirió que la empatía no puede estar ni demasiado elevada ni demasiado baja, de ahí que tengamos que estudiar los excesos y defectos de la misma.

a) Exceso de empatía. Se trata de una exagerada conexión con los semejantes, llegando incluso a olvidar las propias necesidades. Es una forma de tener más en cuenta a los demás que a uno mismo, que conduce a postergar los gustos y preferencias propias para acabar olvidándolos. Resulta poco adaptativa pues conlleva el sacrificio propio.

En el ámbito de la Medicina resulta inadmisible, pues conduce a una entrega a los pacientes exagerada y lleva a una implicación emocional que finaliza (si se mantiene un tiempo) en el *síndrome de desgaste personal* del médico o *burn out* y que nosotros pudimos estudiar en profundidad (3). Este fenómeno tiene actualmente mucha importancia para los médicos, dado que se sigue de bajas laborales y de consumo de alcohol y fármacos (ansiolíticos, estimulantes, opiáceos, etc.); recordemos que este profesional tiene acceso directo a muchas sustancias, de las que puede hacerse adicto; ello representa un riesgo comparable al policía que tiene un arma de fuego en su casa.

b) Defectos de empatía. En este caso se simula la empatía para satisfacer las necesidades propias y conseguir los propios objetivos. Pueden llegar a simular emociones y sentimientos que no tienen realmente para provocar el efecto deseado en los demás y salirse con la suya. Llegan al sacrificio ajeno importándoles muy poco.

Los psicópatas se incluyen en este grupo, caracterizándose por no afectarles el dolor ajeno y jugar con la empatía ajena, para lograr sus fines perversos. La ausencia de empatía explica la crueldad, presente también en estos sujetos, y caracterizados por carecer de compasión.

Explicamos brevemente este fenómeno porque merece la pena: cuando una persona normal agrede a otra (aunque sea verbalmente) y contempla en ella los efectos de su acción (p. ej. expresiones de dolor), tales manifestaciones provocan la compasión en el sujeto actor. En cambio, en el psicópata, al no existir la compasión, las muestras de dolor ajena no dan lugar a bloqueo alguno, sino que aumentan la excitación y la necesidad de continuar con la agresión iniciada.

**6.2.5. La empatía en el contexto terapéutico**. La empatía en la consulta médica tiene como misión ayudar a expresar y gestionar las emociones nocivas que se han captado (primer paso) y reconocido (segundo paso) en la interacción médico-paciente. Pero, a menudo la empatía se confunde con actitudes bastante frecuentes en el ámbito clínico:

-La simpatía. Consiste en hacer el encuentro con el paciente agradable (decir algo gracioso, acogida calurosa, mostrarse sonriente, complacer en las demandas, etc.).

-La sintonía. Establecer rápidamente una relación fluida y abierta (mostrar concordancia de criterios, llegar a acuerdos con facilidad, tener las mismas ideas).

-La compasión. Basada en la idea de que el hombre es vulnerable y se debe actuar solidariamente con él; incluso puede llegar a sentirse lástima por el semejante.

La empatía no coincide con ninguna de estas posibilidades pues, como puede comprobarse con facilidad, cualquiera de ellas coincide con los niveles más bajos de este fenómeno (contagio emocional, identificación). En cambio, podemos considerar a la empatía como la *neutral* capacidad para comprender al otro. En el próximo capítulo, cuando estudiemos la entrevista clínica, estaremos en condiciones de explicar cómo se puede llegar a este estado que puede definirse como “ni caliente” (demasiado próximo), “ni frío” (demasiado lejano).

Según parece la empatía de los estudiantes de Medicina desciende a lo largo de los cursos (especialmente a partir del tercer año). Resulta más “apropiado” para pasar de estudiante a profesional cerrarse a la empatía, lo que parece deberse a que: el contacto con los enfermos produce distrés y los fracasos en los comienzos de la residencia producen la impresión de “inutilidad” o de “no servir” para la profesión. De ahí que se pongan mecanismos de defensa de sobra conocidos, como es el caso de ser: racional, distante, técnico o despreocupado.

Aquí podríamos incluir lo que ya se dijo en páginas precedentes, de que la narrativa médica resulta fundamental para poder elaborar lo que se siente en el contacto con los pacientes. La negación de los afectos propios y volverse frío, técnico, distante o un "pasota" no ayuda en nada en la práctica diaria; por el contrario, el reconocimiento de los afectos propios desencadenados en la práctica diaria y su correspondiente elaboración subjetiva conduce a la tranquilidad. Ya se indicó que el pensamiento es capaz de atemperar las emociones, con lo cual estas no se acumulan y se convierten en algo peligroso.

Resta decir que la empatía en el contexto clínico pretende: comprender al paciente al máximo de las posibilidades, ofrecerle apoyo y ánimo mostrando que merece el tiempo y el esfuerzo y ayudarle a gestionar las emociones incitándole a que reflexione sobre las mismas para que puedan modularse. Para conseguirlo, hacen falta una serie de competencias, a saber: desarrollar la capacidad para imaginar lo que el otro siente y la de expresar y comunicar que se ha comprendido.

### 6.3. La asertividad.

**6.3.1. ¿Qué es la asertividad?** El término viene del latín *assertus*, que se refiere a una "afirmación sobre la certeza de algo". Se trata de una actitud personal arraigada que: a) tiende a afirmar con convicción y firmeza ideas, sentimientos y/o deseos, sin ambigüedades ni matices y b) se mantiene aún en circunstancias desfavorables o adversas.

Evidentemente, no todas las personas son asertivas y, las que lo son, comunican y defienden sus propios derechos e ideas de una manera adecuada, respetando a los demás. Una cuestión importante: ser asertivo no implica tener razón, simplemente se pone de manifiesto el punto de vista propio frente al de los demás, que puede estar equivocado pero es *su* perspectiva ("efecto subjetividad").

**6.3.2. La asertividad en el ámbito clínico**. En este contexto se ha desarrollado un modelo de práctica médica que se ha denominado *Medicina Asertiva* que se opone drásticamente a la *Medicina Defensiva*. Vamos a estudiar cada una de ellas por separado.

**A) La Medicina Defensiva**. Se caracteriza por:

-una extrema seguridad en la práctica médica para impedir demandas y reclamaciones y

-conductas evitativas o de retirada para hacer desaparecer la posibilidad de riesgos.

Estas actitudes y comportamientos han sido considerados una mala praxis por centrarse en el médico para protegerse, olvidándose del paciente, lo cual choca con los modelos asistenciales contemporáneos (ver capítulo 4º). Puede ser normal en residentes y en los primeros años de práctica médica general o especializada, debido al miedo que la propia actividad genera (miedo a equivocarse o fallas). Pero, cuando se encuentra más arraigado, se asocia a una actitud paranoide relacionada con las actuaciones médicas, que se acompaña de: desconfianza, suspicacia, estado de alerta ("estar pendiente") y, a veces, de intentos constantes de descubrir motivaciones "ocultas".

Esta práctica aberrante ocasiona graves consecuencias sobre la comunicación con el enfermo:

-No existe una implicación por parte del médico, con el correspondiente distanciamiento.

-Se siente "doble agente", al tener que centrarse al mismo tiempo en el paciente y en la organización administrativa. Esto provoca un grandísimo desgaste personal, al tener que estar de acuerdo con las dos partes junto a dificultades en la toma de decisiones (p. ej. el paciente pide que se realice una prueba, pero esta es muy cara y tiene que estar bien justificada la petición).

-Elude preguntas y se remite al informe. Muchas veces este está escrito sin una firma definida (especialmente en urgencias), con idea de sortear cualquier responsabilidad ante la aparición de complicaciones.

-El paciente no sabe quién ha tomado las decisiones.

El resultado de esta práctica es la insatisfacción en la práctica médica, tanto del paciente como del médico.

**B) La Medicina Asertiva**. Se desarrolla como contraposición a la anterior y tiene que ver con una actitud del médico en la que mantiene sus criterios, sobre una fundamentación en la clínica (manifestaciones sintomáticas) y en los hallazgos pertinentes (signos y pruebas).

Pero, hay que tener en cuenta lo siguiente: en el ámbito médico la asertividad ha perdido ese carácter de firmeza que tenía inicialmente por el de amabilidad, procurando no llevar hasta un extremo la *función promotora* de la comunicación, como sucedía en el antiguo *modelo paternalista*, donde el médico controlaba la relación y el paciente se hallaba exento de cualquier responsabilidad. Este planteamiento resulta coherente con lo que se ha explicado en los capítulos precedentes, ya que con esta actitud de la asertividad, entendida en el sentido moderno, el médico:

-es capaz de escuchar el punto de vista de su paciente, para poder llegar a un entendimiento,

-mantiene la calma y se pone en el lugar del otro, comprendiendo sus razonamientos y conducta,

-intenta no molestarlo, estando proscrito ofender, atacar, herir, reprochar o menoscabar al paciente, a sus ideas u opiniones; cualquiera de ellos provoca un corte en la comunicación haciéndola inefectiva,

-nunca se recurrirá a la imposición (*función promotora*); subyace un equilibrio entre no expresar (pasividad, docilidad) y expresar de modo exagerado (agresividad) y

-Se negocia el cumplimiento, pero con seguridad.

En consecuencia, la Medicina Asertiva es aquella en la que el médico expresa directa y abiertamente lo que piensa y propone hacer, tal como sus conocimientos y sentimientos le dictan, de una forma simple, clara y oportuna, sin imponer nada al paciente (modelo paternalista), sino consiguiendo acuerdos satisfactorios por ambas partes. Se trata, pues, de una cooperación con el fin de llegar a una solución del problema, de "mojarse" en la relación y no de retraerse, como hemos visto en la Medicina Defensiva. No se deja influir por las prevenciones dictadas por esta última; si actúa según estos presupustos, se convierte en un estímulo de confianza para el paciente.

Una actitud como la descrita puede aprenderse y, al mismo tiempo, ser independiente de la personalidad (p. ej. un médico puede ser "pasivo" y "dependiente" en sus relaciones cercanas, pero con sus enfermos actuar asertivamente para que la relación funcione y la comunicación fluya).

**BIBLIOGRAFÍA.**

1. Darwin Ch. La expresión de las emociones en los animales y en el hombre. Madrid: Alianza, 1984.
2. Lacan J. El estadio del espejo como formador del yo tal como se revela en la experiencia psicoanalítica. En Escritos (vol. 1). Madrid: siglo XXI, 1977.
3. García Arroyo JM. Subjective aspects of Burnout Syndrome in the Medical Profession. Psychology 2014; 5(18). 2064-2072.

## Capítulo 7º. La entrevista clínica: concepto, encuadre, tipos, movimientos afectivos y fases.

### 7.1. ¿En qué consiste una *entrevista clínica* (EC)?

La cuestión a plantear en este capítulo es si el médico necesita conocer los promenores psicológicos de sus pacientes en su quehacer diario. La respuesta es afirmativa dado que, como se verá, intervienen (de manera directa o indirecta) en la enfermedad y, además, la historia clínica no puede estar completa si estos no quedan reflejados de algún modo. Los distintos aspectos psicológicos (o psicosociales) de los enfermos pueden evidenciarse en la *entrevista clínica*.

Cuando hablamos de *entrevista* nos referimos a un proceso de comunicación, en forma de conversación, que se establece entre el médico (psiquiatra o no) y su paciente, cuya finalidad última consiste en solucionar un problema de salud (orientando el diagnóstico y el tratamiento). Hay que diferenciarla del simple placer de conversar, ya que a los amigos los escogemos pero no a los pacientes; de ahí que estos no tienen que caernos bien y, a veces, pueden resultar repulsivos.

> *Este es el caso de uno de ellos, que presentaba un cuadro de ansiedad severo, que se acompañaba de una sudoración de un olor muy desagradable y penetrante. Cuando se marchaba, la consulta tenía que airearse bien durante un buen rato y, como cabe entender, el contacto con él no era demasiado agradable. La mejoría progresiva de la ansiedad hizo que, afortunadamente, el olor que desprendía disminuyera.*

Para determinar la naturaleza del problema y orientar el caso, no basta con recoger la patología física, sino que se impone conocer a la persona, especialmente sus hábitos, estilo de vida, personalidad, creencias, etc. Además, conviene identificar el sustrato psico(pato)lógico (1) de los problemas de salud que aqueja a la persona; muchas veces mediante una entrevista es posible revelar síntomas psíquicos que se encuentran ocultos y hasta puede resultar impensable que la persona que tenemos delante realice ciertos comportamientos.

Cualquier médico, tenga la especialidad que tenga (urólogo, dermatólogo, internista, intensivista, familia, etc.), tiene la obligación de detectar síntomas psíquicos en sus pacientes (fobias, ansiedad, obsesiones, somatizaciones, tristeza, etc.). Pensemos, a título de ejemplo, que las somatizaciones se encuentran diseminadas en todas las especialidades (asma, ulcus, colon irritable, dolor, prurito vulvar, etc.).

Para hacer una buena entrevista se requieren destrezas sociales (lo que se llama “tacto”), pues en ella confluyen elementos técnicos junto con las habilidades inherentes a la capacidad de establecer una relación humana. Para que se entienda bien este punto, nada mejor que citar un caso histórico:

*En 1946 el psiquiatra de origen judio Leon Goldensohn fue llamado para realizar un informe de los jerarcas nazis acusados en el Juicio de Nuremberg, dado que estos podían alegar locura. Entre ellos se encontraban: Herman Göring, Rudolf Höss o Von Ribentrop. Pasó más de seis meses visitando a los acusados todos los días y realizó entrevistas brillantes en las que logró sacarles ciertos secretos, mientras negaban sistemáticamente cualquier implicación en el Holocausto. Muere de tuberculosis (en 1961) cuando iba a publicar los resultados de sus entrevistas. El objetivo de este psiquiatra era ganarse la confianza de los entrevistados y lo logró; consiguió que confesaran el uso de Zyklon B, un pesticida que contenía ácido prúsico (cianuro de hidrógeno), con el que habían aniquilado a una gran cantidad de judíos en las cámaras de gas.*

Cuando la entrevista se realiza bien, se logra desarrollar y mantener la relación terapéutica e implicar al paciente en su tratamiento.

Antes de proseguir, conviene atender a dos cuestiones interesantes:

1ª. ¿En qué se diferencia una EC de la que se puede realizar en el Departamento de Personal de una gran empresa para contratar a alguien? La respuesta consiste en que, en estos lugares, se procuran dirimir las actitudes (cuál es su disposición hacia ese trabajo) y las aptitudes (qué habilidades posee) del aspirante. En cambio, el médico centra su atención en determinar cuáles son los aspectos subjetivos que se encuentran implicados en la aparición, mantenimiento, reacciones y mecanismos psicológicos ante la enfermedad, cuáles de ellos pueden interferir en el tratamiento y como debe ser tratado el paciente para que el proceso asistencial funcione mejor (p. ej. a un sujeto con rasgos de rebeldía no se le puede tratar autoritariamente, de una persona incapaz de hacer un compromiso no se puede esperar que haga el tratamiento tal como se le indica, del mentiroso habitual no es posible pensar que en la consulta diga la verdad, etc.).

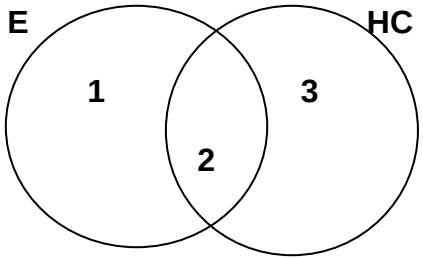
2ª. La informacion obtenida a partir de la entrevista queda reflejada en un documento: la *historia clínica* (HC). Entonces, la nueva cuestión: ¿todo lo captado en la entrevista debe quedar reflejado en la HC, incluidos los aspectos más personales del paciente? Evidentemente que no, por dos razones:

-Legales: un juez puede pedir la historia en cualquler momento.

-Privacidad: puede vulnerarse cuando otros profesionales (médicos o no) pueden acceder al sistema informático y conocer los pormenores contenidos en la historia y también porque, por un servicio médico pueden pasar muchas personas (residentes, contratados, estudiantes, eventuales, etc.). De todas maneras, debido a la influencia de Ley de Protección Datos se intentan extremar las precauciones sobre el material informatizado.

En definitiva, es el médico quién debe decidir qué incluye en la HC, qué es oportuno que figure y qué debe excluir. Esta apreciación abre tres campos posibles en las relaciones entre EC e HC, tal como se aprecia en el siguiente esquema:

a) En el 1, aparece aquel material de entrevista que no debería figurar en la HC, consformándose como un material privado. Tal es el caso de ciertas impresiones personales del médico o sospechas sobre el paciente, la familia o la pareja; también lo que siente en el contacto con el enfemo (contratransferencia). Estos aspecto pueden quedar reflejados en un documento privado al que nadie tenga acceso (¿tal vez una libreta Moleskine?) y lo escrito puede servir para pensar cómo se siente, qué inseguridades tiene respecto a la práctica (p. ej. con el tratamiento), qué le choca del comportamiento del paciente, qué es lo que no le cuadra, las contracciones que se producen en el ejercicio, etc.




b) En el campo 2, tenemos lo que se escribe en la HC que, hasta cierto punto, es un material "público", ya que son varios los profesionales que tendrán acceso a ese documento. Aquello que queda reflejado en la HC debe exponerse:

-con una terminología médica impecable que convierte el texto en imparcial (argot o lenguaje especial que usamos los médicos y que, fuera de este contexto, no se entiende) y

-con forma narrativa. Ya se dijo antes que la HC tiene que adoptar la forma de un relato bien contado.

c) En el campo 3 figura aquello que aparece en la HC y no se ha obtenido a partir de la entrevista (p. ej. resultados de las pruebas diagnósticas, analíticas, tratamientos que se le han puesto, etc.).

En la actualidad, la Guía Calgary-Cambridge (Guía de Observación Calgary-Cambridge: CCOG) se considera la base para los estudios de entrevista médica y consta de 71 habilidades de comunicación (se encuentra disponible en internet para quién quiera consultarla). Representa un esfuerzo para mejorar la relación médico-paciente, que degeneró bajo la presión del modelo biomédico llevado hasta sus últimas consecuencias.

**7.2. El encuadre**.

Cuando se realiza una entrevista se requiere un *encuadre*, que consiste en el conjunto de normas que la regulan el comportamiento durante la misma, tanto para el médico como para el paciente (p. ej. si he quedado con un enfermo a las cuatro menos cuarto de la tarde, puedo estar cansado y harto de trabajar, pero tengo que acudir). Dentro del encuadre se incluyen tres elementos:

**7.2.1. El espacio**. Siempre debe hacerse en una consulta médica, que resulte: confortable, cómoda y sin ruidos ni interrupciones. Cualquier intento de que una entrevista se realice fuera de este contexto, debe acompañarse de una negativa:

> *En una ocasión la portera de mi bloque llamó a mi puerta y me preguntó si podía atender a su hijo de 18 años, porque había recibido información de que fumaba porros. Mi respuesta fue afirmativa y, tan pronto como fui a por la agenda para darle la cita, me dijo que él nunca acudiría a mi consulta y que ibamos a hacer lo siguiente: "le voy a decir en qué discoteca se reune con sus amigos, porque siempre va a la misma y se coloca en el mismo lugar. Usted va allí y se presenta diciéndole que es médico y amigo de la familia y que está allí para ayudarlo". Evidentemente, no fui.*

Como decimos, es un peligro la realización de una entrevista psicológica en un lugar que no sea la consulta, precisamente porque esta última define el contexto en el que se realiza el acto médico.

**7.2.2. El tiempo**. No debe ser ni mucho ni poco; normalmente está bien entre 30 y 45 minutos. Más de ese tiempo es raramente beneficioso, aunque al paciente le queden muchas cosas por decir (los verborreicos no paran de hablar y si se les deja, pueden llevarse todo el día contando sus problemas). Si se necesita más tiempo, pueden programarse nuevas entrevistas.

No obstante, deben hacerse entrevistas breves en aquellos casos de: personas poco colaboradoras, psicóticos, depresivos profundos, dementes, estuporosos y agitados.

**7.2.3. La técnica**. Antes de meternos de lleno en este apartado, anunciados dos nuevos "axiomas de la comunicación", que pueden añadirse a los ya estudiados (ver capítulo 1º):

1º. No es cierto lo que dice el emisor, sino lo que entiende el receptor.

2º. El responsable de todo el proceso comunicativo es el emisor.

Son muy importantes ya que expresan el esmero que tiene que poner el médico en la entrevista para asegurarse de que el paciente ha entendido.

La técnica vamos a estudiarla en relación a los “cuatro ingredientes básicos para el desarrollo de una buena entrevista”, que son**:** la empatía, la calidez, el respeto y la concreción. Aquí vamos a tratarlos desde el punto de vista técnico, para no repetir lo dicho en capítulos precedentes.

**A. La empatía**. Es la capacidad de entenderse, sintonizar e interactuar con el paciente y tiene lugar a nivel verbal. Evidentemente, si el paciente siente que se le está entendiendo se va a expresar más y mejor durante la entrevista; luego hay que actuar empáticamente para que se produzca más material durante el diálogo.

Sabemos actualmente que la satisfacción del paciente se basa más en la relación interpersonal que establece con su médico que el nivel conocimientos de la especialidad que este posea. De hecho, los pacientes valoran de su médico (por orden de preferencia): 1º) la calidad humana, 2º) la información que facilita, 3º) los servicios en general y 4º) la competencia técnica del profesional. Sorprende reconocer que el nivel de especialización y de conocimientos se va al último puesto.

**B. La calidez**. Se trata de la proximidad afectiva entre médico y paciente y se pone de manifiesto a nivel no verbal. En relación a este punto hay que tener en cuenta los siguientes aspectos:

-La actitud tiene que ser acogedora, regulando la proximidad. Aquí se incluye no tratarlo como a un conocido, ni permitirle la invasión; en este último caso habría que poner límites.

-Se trata de una relación profesional. No es una amistad, ni un flirteo, ni un compadreo, ni tampoco está permitido aprovecharse del paciente.

-Implica también manejar adecuadamente las emociones; en este sentido: se toleran las descargas pero se estimulan y, si estas son demasiado exageradas durante el encuentro e impiden el diálogo, conviene amortiguarlas (“intente no llorar, es necesario para obtener más información”).

-En cuanto a la toma de notas está permitido, pero puede ser contraproducente en aquellos sujetos que tienen rasgos paranoides. En estos últimos, conviene no escribir nada y, más tarde, reconstruir lo que ha dicho cuando ya no esté presente.

-El uso de grabadoras durante una entrevista tiene lugar solo en las películas. Habitualmente carecen de utilidad y, de usarlas, no habría tiempo material para escuchar tantas grabaciones y, además, pueden despertar suspicacias (“¿quién más va a escuchar lo que he dicho?”).

**C. Respeto.** Se trata de preservar la forma de pensar y los valores del paciente. Se encuentran proscritas las siguientes actitudes: hacer juicios de valor

o críticas, entrar en discusión, tratar de quedar por encima, intentar solucionarle los problemas (solo el paciente es responsable de su vida) o dar consejos si no los pide.

Se habla del "síndrome del experto" cuando el profesional sanitario ya tiene la respuesta antes de que se formule el problema; muchas veces, estas soluciones prematuras actuan como un "tapaboca" para que no siga hablando.

**D. Concreción**. Dado que el tiempo de la entrevista no es elástico (ver el *encuadre*), se deben delimitar objetivos mutuos y compartidos. Existen muchos pacientes que se van por las ramas y cuentan datos superfluos, en tal caso es mejor redirigir ("creo que estaba hablándome de su consumo de tabaco ¿no es cierto?). Si hay poco tiempo, se le debe explicar que puede expresar lo que quiera, pero que sería muy importante que se atuviera al tema.

### 7.3. Tipos de entrevista.

Básicamente existen dos formas de hacer una entrevista:

**A. Centrada en el médico o *directiva*.** En ella el médico toma la iniciativa y pregunta directamente (¿a qué se dedica? ¿su madre vive aún? …), mientras el paciente se dedica a aportar la información requerida. Limita la expresión del paciente, al restringir las posibilidades de respuesta (suelen ser monosilábicas).

Es la que se realiza en los servicios de urgencia, dado que rápidamente hay que determinar si el sujeto se queda ingresado o no y en qué condiciones (observación, planta, UCI, etc.).

**B.. Centrada en el paciente o *no directiva*.** Se deja la iniciativa al paciente, mientras el médico apenas pregunta; si lo hace las preguntas han de ser abiertas. El resultado es el relato espontáneo de la persona, quién va configurando la entrevista de acuerdo a sus propias necesidades (narrativa).

Se utiliza en el resto de los servicios médicos, donde hay tiempo suficiente para poder obtener más datos del paciente.

Vienen muy bien algunas indicaciones sobre las preguntas a realizar durante la entrevista; a ser posible estas deben: a) ser abiertas, b) evitar las preguntas directas, ya que el paciente puede cerrarse (p.ej. ¿cómo? ¿otro que se droga?), c) evitar las preguntas íntimas sin preámbulos o sin explicación de por qué se realizan, aunque puede ir centrándose progresivamente en el tema, d) no hacer preguntas de curiosidad y e) no inducir respuestas (p. ej. ¿verdad que usted ya no quiere a su marido?).

### 7.4. Movimientos afectivos durante la entrevista.

En la interacción que tiene lugar durante la entrevista se movilizan los afectos, de tal manera que existen dos modos bien definidos:

a) Los que van del paciente al médico: *transferencia*. Trátase de expectativas, creencias, sentimientos o reacciones emocionales dirigidas al médico (p. ej. el enfermo apenas habla porque teme la crítica del médico o, por el contario, habla exageradamente para conseguir su estima).

b) Los que se dirigen del médico al paciente: la *contratransferencia*. Siempre el paciente despierta algo en nosotros, tratándose de sentimientos, deseos, expectativas, etc. Depende de lo que espere del paciente en relación con su personalidad (p. ej. un médico con rasgos obsesivos se enfada con los que llegan tarde o no cumplen a rajatabla el tratamiento, en consecuencia el paciente, conociendo como es termina mintiéndole o diciéndole lo que quiere escuchar). Del mismo modo, ciertas actitudes conocidas del paciente movilizan algo en nosotros (p. ej. el que viene a solicitar informes y no cuenta para qué los quiere).

La transferencia puede expresarse dentro de unos cauces, pues si el consultante se pasa en algún sentido (p. ej. falta el respeto o insulta) hay que ponerle límites. El problema de la contratransferencia es otro: no se puede expresar de ninguna manera, de ahí que la única solución sea elaborarla mentalmente, lo que significa emplear el pensamiento racional para analizar qué se está sintiendo y ponerla en palabras (*narrativa médica*). Evidentemente, si el médico se conoce bien a sí mismo tiene bastante terreno ganado.

Si se realiza el análisis de la *contratransferencia* es posible colocarse en la posición de *neutralidad*. Como hemos dicho ya varias veces, no se trata de de estar próximo, ni tampoco lejano, sino de adoptar una actitud acogedora que no expresa ningún afecto y que coloque en disposición de escucha. Ya se dijo que la empatía no es ni ser chistoso, ni ser demasiado cortés, ni tener una amabilidad exagerada, ni pelotear al paciente, ni estar feliz de recibirle, etc., sino la neutral capacidad de comprender al otro (ver capítulo 6º). Implica no tener que defenderse de lo que manifiesta, marcando distancia o creando una frialdad, sino de aceptar lo que está narrando. Solo cuando se analiza la afectividad implícita en el acto médico es posible conseguir la *objetividad*. La siguiente fórmula así lo pone de manifiesto:

$$Ob = Cont - Af$$

Se lee: “la objetividad es igual al contenido producido por el paciente menos la afectividad”, es decir que hay que descontar la afectividad del acto médico (mediante el análisis de la misma) para ser objetivo. Esto mismo explica por qué no podemos serlo con las personas más cercanas; queda claro que aquí la afectividad es in-descontable.

Resulta importante ahora estudiar la contratransferencia en relación a la personalidad del médico, dado que esta da lugar a actitudes y espectativas sobre los pacientes que conviene conocer. Analizamos seguidamente los tipos más conocidos:

1. El médico *histriónico*. Intenta quedar bien y ser amado y querido por sus pacientes. Busca restaurar su autoestima a través de su profesión. No escucha lo que no le interesa y no habla con quiénes le consultan sobre ciertos asuntos (mecanismo de represión). A menudo tiene fantasías de curación, que pueden ser exageradas (*furor curandis*) que pueden acompañarse de desilusion, tan pronto como comprueba como es la realidad clínica.

2. El médico *obsesivo*. No se sale del plan establecido o del protocolo, ritualizando su profesión, lo que muestra su rigidez mental. Se mueve en el plano teórico en exclusiva, evitando la parte afectiva del encuentro. Procura controlarlo todo (control omnipotente) y se hace responsable de cuanto pasa, lo que puede llegar a producirle sentimientos de culpa con facilidad.

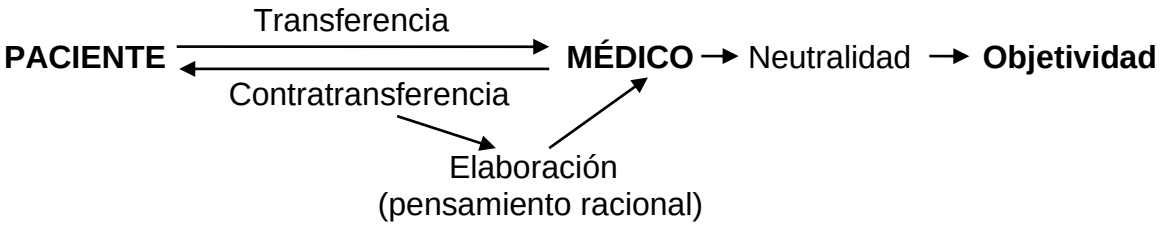
3. El médico *fóbico*. Procura estar a buena distancia del paciente y mantenerse aséptico para no verse implicado en nada pero, al mismo tiempo, teme el rechazo. Deriva rápidamente a los pacientes por miedo (evitación) y, a veces, practican la Medicina Defensiva por la misma razón.

4. El médico *narcisista*. Intenta sacar el máximo partido a la relación médico-paciente para ganancia propia (lucro, fama, prestigio, publicaciones, dinero, etc.). En este afán, puede saltarse ciertos valores o normas. Devalúa y critica a los compañeros, con los que mantienen una competencia feroz. Muestra una incapacidad para el trabajo en equipo, debido a no aceptar ser uno más (necesita ser el mejores o el “único” en su género).

5. El médico *perverso*. Se sirve de los pacientes para satisfacer sus propios impulsos (visionado, provocar dolor, aprovecharse sexualmente, tocar, etc.). Pueden realizar el paso al acto (*acting out*), desplegando el impulso en la realidad y no en la fantasía; si lo hace, a continuación procede a negarlo (“es imposible yo no lo hice”) o a justificarlo (“era necesaria esa exploración”).

6. El médico *psicótico*. Es una persona incapaz de empatizar y, frecuentemente, responde desconfiando (del paciente/de la administración). Hace recomendaciones mágicas a sus enfermos (ungüentos, pócimas, pomadas, etc.) que, evidentemente, no tienen ningún efecto sobre la enfermedad.

Si se elabora bien la *contratransferencia* (y se adopta la posición neutral), se genera la capacidad de entenderse o sintonizar y la relación se hace armoniosa (*rapport*), no poniendo en riesgo el tratamiento ni su continuidad.




### 7.5. Fases de la entrevista.

Por muy breve que sea una entrevista siempre hay que seguir un recorrido, que es el siguiente:

**7.5.1. Apertura.** Ha de comenzar como una expresión de amplio significado (p. ej. "¿en qué le puedo ayudar?"; nunca emplear: ¿qué problema tiene?"). Si ya se le conocía de antes y se pretende indagar en los aspectos psicológicos implicados en la patología, se le puede decir: "bueno, vamos intentar hablar un poco sobre cómo se encuentra. Me gustaría escucharle para saber un poco más sobre su vida, su enfermedad, en fin, lo que quiera contarme". Solo empleando este tipo de expresiones es posible obtener más datos de la persona encuestada. Es importante mantener con él un contacto ocular y nunca centrarnos en el ordenador; de esta forma el paciente sabe que capta nuestra atención.

Mientras habla podemos obtener de él las "primeras impresiones", importantes de analizar en este momento inicial de la entrevista, como son: la apariencia general (vestimenta, aseo, objetos extraños, gestos, muecas, peinado, …), la conversación (modales, educación, repeticiones,…), la mirada ((fija-amenazante, huidiza-temorosa, ausente, …), viene solo o acompañado, desea tener la entrevista, etc.

> *Un paciente nuestro llevaba colgado en una cadena de oro un rabo de conejo, que llamaba poderosamente la atención. Preguntado al respecto, respondió: "los conejos son seres muy astutos y yo con esto (se señala el colgante) voy a tener la astucia del conejo". Al tiempo que decía esto hacía una mueca, moviendo la nariz, como si se tratara de este animal.*

Este primer momento de la entrevista sirve también para crear un clima afectivo de mutua confianza, suficiente como para que sea capaz de abrirse y contar sus dificultades y problemas, en el segundo momento. Se le puede estimular para que se sienta cómodo, con frases como: "no se preocupe, tenemos tiempo y podemos hablar de lo que le apetezca", "aquí puede contar lo que desee, porque se trata de una conversación privada y nadie va a enterarse", etc. Téngase presente que la mayoría de los pacientes vienen angustiados al médico y una de las funciones de la entrevista es disolver, si no toda, al menos una parte de esa angustia.

La postura del médico en esta fase debe ser de mostrar maestría (sabe lo que hace o lo que tiene entre manos) sin ser autoritario, es decir, seguro pero no directivo. Estos dos términos se confunden frecuentemente y se cree que ser "seguro" es sinónimo de "dirigir" y no tienen nada que ver entre sí (ver Asertividad, apartado 6.3).

**7.5.2. Desarrollo**. En esta fase se recogen los rasgos, actitudes, hábitos y síntomas del sujeto, teniendo cuidado ya que el paciente puede:

-Simular. Inventa síntomas con los que espera obtener un beneficio (conseguir un certificado, tener ventaja en un juicio, etc.). Muchos de ellos, suelen ser remitidos por compañías de seguros o aseguradores, inspectores médicos, etc.

-Disimular: oculta manifestaciones sintomáticas o rasgos para que no se vean y no queden registrados.

Para captar bien estas posibilidades, conviene comprobar las incongruencias entre lo qué me dice y lo observado. El psiquiatra León Goldensohn, del que ya hablamos al principio del capítulo, descubre, en sus entrevistas a los jerarcas nazis, la disarmonía existente entre lo que creen y lo que hacen realmente. Lacan hablaba, en relación a este tema, de la "división del sujeto" (2).

Un asunto importantísimo a recoger en el desarrollo de la entrevista es el correspondiente a qué ocultan los pacientes y por qué. En este sentido, muchos de ellos mienten u ocultan información y elementos personales que pueden ser importantes para la historia clínica pasan completamente desapercibidos en las entrevistas convencionales o rápidas. Lo que suele ocultarse (aparte de ciertos hechos familiares, como es el caso de los suicidios) es el *goce*. Trátase de una temática compleja de explicar, sobre todo cuando se tiene la mente demasiado volcada en los aspectos biológicos (anatomía, fisiología, histología, etc.); de ahí que, para que se entienda bien, tengamos (obligatoriamente) que utilizar un ejemplo:

> *El mejor sitio de Sevilla donde ponen la ensaladilla de gambas está en la Plaza del Salvador, tratándose de un verdadero manjar porque las gambas son cocidas junto con las patatas y estas últimas se esponjan con el sabor.*
> *Si uno llega allí, después de una mañana de trabajo, pide una caña con una tapa de ensaladilla. ¿Qué se siente? Evidentemente, placer y así es, ya que la cerveza fría refresca las mucosas recalentadas y el sabor de la ensaladilla parece que restablece (1ª conducta).*
> *Pero, la chica que pone estas maravillosas viandas tiene que insistir en que la gente consuma (su contrato depende de ello) y entonces dice: "¿quiere*

*otra?". La respuesta está cantada: "¡póngala!". ¿Qué se siente? Se sigue sintiendo placer (2ª conducta).*
*Mas, la insistencia continúa: "¿quiere una más?". La respuesta es no ¿por qué? Porque si se sigue consumiendo, se empieza a notar cierto malestar: distensión gástrica, sensación de llenado, cierto mareo o inestabilidad, etc. ¿Qué se siente entonces? Respuesta: una mezcla extraña entre placer y dolor. Y, si se sigue consumiendo, el malestar va tomando cada vez más la delantera y el placer disminuye hasta disiparse por completo.*

¿Qué ha sucedido? La primer conducta (C1) ha procurado placer, la segunda igualmente (C2), pero la tercera (C3) ya empieza a producir dolor y en las siguientes (C4 en adelante) aparece un franco malestar. Por lo tanto, el *goce* consiste en una mezcla entre placer y dolor.

¿A qué se debe esto? ¿tiene algún fundamento fisiológico? Cada parte del cuerpo nos aporta una dosis determinada de placer, pero no más (p. ej. si estoy viendo una película bien, pero si me llevo toda la tarde tirado visionan películas una tras otra ya no siento lo mismo).

*Este es el caso de un paciente nuestro, que padece una "satiríasis": solo quiere tener relaciones sexuales de forma constante, no importándole con quién. Incluso, en la cabecera de su cama tiene un ábaco en el que va consignando cada uno de los orgasmos que consigue. El mismo lo dice: "las primeras veces que lo hago en el día, estoy a gusto, me lo paso muy bien. Después, es triste porque para mí eyacular es lo mismo que orinar, pues no siento nada".*

*Un paciente de 28 años, acude a una despedida de solteros en Cádiz. Deciden contratar a unas estripers y se lo pasan bien mientras se desnudan pero, después de un cierto tiempo (no demasiado largo) alguien del grupo dice: vámos a tomar unas copas, que ya está bien. Se trata de la saturación correspondiente y que, de seguir la estimulación, ya no produce absolutamente nada.*

Las características del *goce* que lo diferencian del *placer* son las siguientes:

1. No tiene medida, ni límites. El límite finalmente lo pone el cuerpo (p. ej. si bebo mucho, termino vomitando y "hecho un trapo").

2. Es una forma de (auto)destructividad: se juega con la muerte (pensemos en alcohólicos, toxicómanos, consumidores de ansiolíticos, ludópatas, etc.).

3. Aumenta el riesgo de enfermar o morir.

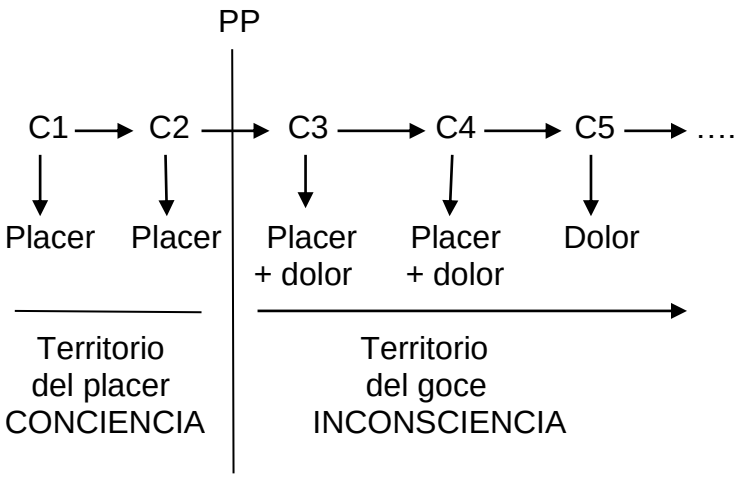
4. Se encuentra en la base de las llamadas *conductas de riesgo*, de ahí la importancia que adquiere en las entrevistas clínicas.

5. Es también el sustento de los comportamientos de búsqueda de emociones, propios de personas vacías.

6. Considerado por la sociedad como "repudiable" (a nadie le gusta una persona que se lleva horas jugando a las maquinitas, pegado al móvil, fumando, comiendo, viendo películas sin parar, matándose en un gimnasio, etc.). Curiosamnete, existen numerosos adjetivos que definen a estas personas y que están muy extendidos.

7. Mientras el sujeto se desenvuelve en el territorio del *placer* es consciente pero, en el momento en que pasa al del *goce* es inconsciente, pues una conducta lleva a la otra y la otra a la siguiente y así sucesivamente, sin poder parar.

Entran en el campo del *goce*: consumo de tóxicos, alcohol, alteraciones alimentarias (bulimia, anorexia, ingesta excesiva de hidratos de carbono), acciones auto y heteroagresivas, prácticas sexuales exageradas o de riesgo, vigorexia, ludopatía, las nuevas adicciones, etc. Se comprende de modo claro por qué el paciente oculta su modo de gozar y cómo siente vergüenza cuando tiene que contarlo en la consulta médica. Si los comportamientos son ilegales (p. ej. la cocaína), se recurre a la mentira y al engaño y, si hacen mienten en la calle, también lo harán en la consulta.




¿Cómo se para esto? Con órdenes o mandatos no se puede; esto es, justamente, lo que sucede con "las promesas de primero de año" ("voy a hacer dieta y comer mucho menos") y el resultado es que todo va a peor (un par de meses después viene el atracón, que hace sentirse culpable a la persona); consecuencia: una prohibición provoca la realización de más goce. Entonces ¿cuál es la solución? La única respuesta posible es que el propio "principio del placer" (PP) es el "límite del goce"; quiere decir que si soy capaz de disfrutar con lo que hago o si aprendo a hacerlo (p. ej. tomando solo dos tapas de ensaladilla

de gambas y disfrutándolas), no tengo por qué seguir más allá (p. ej. terminar vomitando y aborreciendo las gambas para siempre). El problema es que muchas personas son incapaces de disfrutar con lo que hacen, viéndose obligadas a seguir en el intento de alcanzar algo que nunca les llega.

Si el médico, durante esta fase de la entrevista, posibilita un clima de sosiego y confianza con el paciente, este puede abrirse y sacar el material oculto. En nuestro caso, lo hemos conseguido aún en los casos en los que el goce era "maligno": personas cuyas conductas se hallaban al margen de la legalidad y/o con él provocaban daño a los demás (p. ej. robo, sometimiento, pillaje, venta ilegal, tráfico de estupefacientes, etc.). Obviamente, existe un factor de aprendizaje en todo esto que decimos, pues a medida que el médico hace más entrevistas, es capaz de hacerlas mejor obteniendo en ellas una información más relevante. En el siguiente esquema queda claro que el clima que se crea en la consulta (con mucho "tacto", como Goldensohn) es capaz de disolver las capas ocultamiento, que se usan para que el goce quede oculto.




**7.5.3. Cierre.** Llegamos al final de la entrevista y, en este momento, se le debe devolver alguna información de la obtenida al paciente; esta tiene que ser comprensiva, adaptarse a la persona y a lo que tenemos, utilizando sus mismas palabras y aclarando las dudas que pudieran aparecer.

. Si se da por concluida la entrevista y el paciente intenta reabrirla, se le responde amablemente que se ha terminado y ya se le ha informado de cuánto es posible. Nunca acabar dando la impresión de que es el fin de la relación; por el contrario, es importante dejar abierta la posibilidad de un nuevo encuentro, aunque este sea improbable. Jamás se de debe decir: "no, usted no tiene que volver más por aquí", porque es como echarlo y nunca se debe dejar desvalido (y sin apoyo) a un enfermo.

**BIBLIOGRAFÍA.**

1. Castilla del Pino C. Introducción a la Psiquiatría (vol. 1). Madrid: Alianza Universidad, 1993.
2. Lacan J. Escritos (2 vols.). Madrid: Siglo XXI, 1977.